



RUMAH SAKIT
PRIMA HUSADA

**LAPORAN TRIWULAN I
KOMITE PMKP RS PRIMA HUSADA
MALANG**

TAHUN 2026

Jl. Banjararum Selatan No. 3-7 Mondoroko - Singosari, Malang

Telp. 0341-458679, 458916, Fax. 441874

Email : sekretariat@malang.rs-primahusada.com

www.rs-primahusada.com

LEMBAR PERSETUJUAN

Laporan Triwulan I Komite PMKP
Rumah Sakit Prima Husada Malang
Tahun 2026

Laporan Triwulan ini disusun sebagai wujud evaluasi dan capaian pelaksanaan rencana kerja PMKP pada Triwulan III Tahun 2025. Program peningkatan mutu ini dijalankan secara objektif dan sistematis guna menilai mutu pelayanan serta tingkat kepatuhan kinerja staf dalam memberikan asuhan pasien di setiap unit kerja selama periode tiga bulan terakhir.

Disusun oleh:
Komite PMKP RS Prima Husada Malang
Malang, 12 April 2026

Disetujui oleh:
Direktur PT Disa Prima Medika

dr. Sefrina Trisadi, Sp.DVE

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan yang Maha Esa, karena berkat rahmatnya penyusunan Laporan Komite PMKP Triwulan I Tahun 2026 Rumah Sakit Prima Husada Malang ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik sehingga dapat dilaporkan kepada Pemilik Rumah Sakit Prima Husada (PT. Disa Prima Medika). Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien dilakukan berdasarkan tersedianya data, penggunaan data secara efektif dapat dilakukan secara *evidence-based* praktek klinik dan *evidence-based management*, berhubung sebagian besar rumah sakit mempunyai sumber daya terbatas, maka rumah sakit tidak dapat mengumpulkan data untuk semua hal yang diinginkan. Jadi rumah sakit memilih proses dan hasil *outcome* praktik klinik dan manajemen yang harus dinilai atau diukur dengan mengacu pada misi rumah sakit, kebutuhan pasien dan jenis pelayanan. Penilaian sering terfokus pada proses yang berimplikasi risiko tinggi, diberikan dalam volume besar atau cenderung menimbulkan masalah. Pimpinan rumah sakit memiliki peranan kunci untuk memastikan rencana mutu dan keselamatan pasien membentuk budaya organisasi rumah sakit dan memberi dampak pada setiap aspek kegiatan berupa Standar Pelayanan Minimal dan pencapaiannya sesuai indikator yang dipergunakan di setiap unit pelayanan di Rumah Sakit Prima Husada.

Dengan tersusunnya Laporan Komite PMKP Triwulan I tahun 2026 Rumah Sakit Prima Husada Malang ini, kami mengucapkan terima kasih kepada tim yang telah membantu terselesaikannya laporan ini sehingga dapat dipergunakan untuk pendekatan sistemik dalam hal aplikasi proses dan pengetahuan yang seragam dalam melaksanakan semua kegiatan mutu dan keselamatan pasien rumah sakit.

Penyusun

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Visi Rumah Sakit Prima Husada adalah menjadi rumah sakit berkualitas prima pilihan seluruh lapisan masyarakat. Untuk dapat mewujudkan visi Rumah Sakit Prima Husada tersebut, maka didukung oleh 3 misi sebagai berikut: 1) Memberikan pelayanan kesehatan dengan aman, tepat, cepat, akurat. 2) Mengutamakan kepuasan dan keselamatan pasien. 3) Meningkatkan mutu pelayanan yang berkelanjutan. Dalam upaya memberikan pelayanan berkualitas prima yang mengedepankan peningkatan mutu dan keselamatan pasien sesuai dengan Standar Akreditasi Rumah Sakit Kementrian Kesehatan (STARKES). Kegiatan ini dilakukan di setiap unit terkait untuk mengukur kinerja pelayanan rumah sakit dan sebagai manajemen kontrol untuk mendukung pengambilan keputusan.

Program peningkatan mutu dan keselamatan pasien Rumah Sakit Prima Husada pada tahun 2025 menetapkan indikator rumah sakit yang sesuai dengan STARKES. Berdasarkan standar PMKP 3, dapat diklasifikasikan indikator rumah sakit sebagai berikut: indikator mutu nasioanal (INM), Indikator mutu sasaran keselamatan pasien, Indikator mutu prioritas klinis rumah sakit, Indikator mutu tujuan strategis, indikator mutu perbaikan sistem, Indikator mutu prioritas unit (IMP-Unit).

1.2 Tujuan

Tujuan Umum

Mengetahui mutu pelayanan dan penerapan keselamatan pasien di Rumah Sakit Prima Husada.

Tujuan Khusus

- a. Mengevaluasi peningkatan mutu dan keselamatan pasien Rumah Sakit Prima Husada melalui pemantauan indikator mutu yang telah ditetapkan pada rapat kerja akhir tahun.
- b. Mengevaluasi pelaksanaan program mutu spesifik lain yang dilakukan oleh tim/ komite/ unit terkait dengan peningkatan mutu dan keselamatan pasien.
- c. Mendapatkan rekomendasi dari dewan pengawas mengenai program mutu pelayanan dan penerapan keselamatan pasien di Rumah Sakit Prima Husada

BAB II

KEGIATAN PEMANTAUAN INDIKATOR MUTU RUMAH SAKIT TAHUN 2026

2.1 Kegiatan Pokok

Kegiatan pemantauan indikator mutu pada Triwulan I Tahun 2026 yang dilaporkan pada Bulan April Tahun 2026.

2.2 Kegiatan yang Dilakukan

1. Melakukan pemantauan indikator mutu secara berkesinambungan
2. Melakukan tabulasi terhadap data hasil pemantauan indikator mutu
3. Melakukan penyampaian hasil pemantauan indikator mutu oleh masing-masing bagian/unit
4. Menyusun laporan hasil pemantauan indikator mutu

2.3 Jadwal Kegiatan

1. Melakukan pelaporan hasil pemantauan indikator mutu oleh masing-masing bagian/unit dilakukan setiap bulan, menyusun program perbaikan mutu oleh tim peningkatan mutu rumah sakit dilaporkan pada saat rapat bulanan.
2. Melakukan tabulasi terhadap data hasil pemantauan indikator mutu
3. Menyusun laporan hasil pemantauan indikator mutu dan keselamatan pasien rumah sakit setiap tiga bulan.
4. Melakukan penyampaian hasil pemantauan indikator mutu

2.4 Pencatatan dan Pelaporan

Pencatatan dilakukan oleh petugas pengumpul data unit, kemudian dilakukan rekapitulasi dan analisa oleh penanggungjawab pengumpul data. Hasil analisis tersebut kemudian dilaporkan ke kepala instalasi/unit, hasil ditulis pada Form Supervisi dilengkapi laporan tindak lanjut program untuk indikator yang belum sesuai dengan standar yang ditetapkan atau setiap ditemukan suatu permasalahan di setiap instalasi kerja dan ditembuskan Sub Komite Peningkatan Mutu.

BAB III

HASIL KEGIATAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Pemantauan Indikator Mutu Nasional

Berikut merupakan capaian indikator mutu nasional RS Prima Husada Malang pada bulan Januari-Maret tahun 2026.

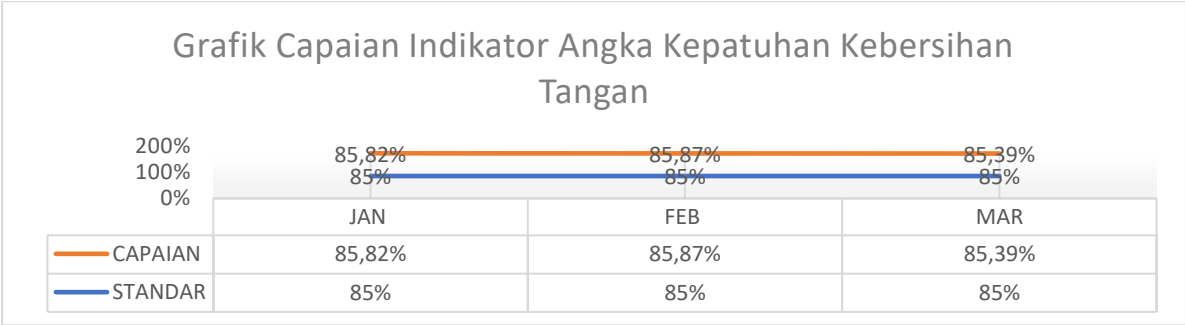
Tabel 3.1 Capaian Indikator Mutu Nasional RS Prima Husada Malang bulan Januari-Maret tahun 2026

NO	Judul Indikator	Bulan			Stan- dar	Rata- Rata	Keterangan
		Jan	Feb	Mar			
1.	Angka Kepatuhan Kebersihan Tangan	85.82%	85.87%	85.39%	≥ 85%	85.69%	Ditingkatkan
2.	Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD)	96.82%	96.88%	96.40%	100%	96.70%	PDSA
3.	Kepatuhan Identifikasi Pasien	99.96%	99.06%	99.89%	100%	99.64%	PDSA
4.	Waktu Tanggap Operasi Seksio Sesarea Emergensi	100.00%	100.00%	100.00%	≥ 80%	100.00%	Dipertahankan
5.	Waktu Tunggu Rawat Jalan	89.90%	86.30%	89.20%	≥ 80%	88.47%	Dipertahankan
6.	Penundaan Operasi Elektif	0.00%	0.00%	0.00%	≤ 5%	0.00%	Dipertahankan
7.	Kepatuhan Waktu Visite Dokter	66.75%	73.63%	68.35%	≥ 80%	69.58%	PDSA
8.	Pelaporan Hasil Kritis Laboratorium	100.00%	100.00%	100.00%	100%	100.00%	Dipertahankan
9.	Kepatuhan Penggunaan Formularium Nasional	86.13%	86.07%	86.45%	≥ 80%	86.22%	Dipertahankan
10.	Kepatuhan Terhadap Alur Klinis (Clinical Pathway)	30.51%	16.11%	18.75%	≥ 80%	21.79%	PDSA
11.	Kepatuhan Upaya Pencegahan	91.77%	93.31%	95.60%	100%	93.56%	PDSA

	Risiko Pasien Jatuh						
12.	Kecepatan Waktu Tanggap Komplain	100.00%	100.00%	100.00%	≥ 80%	100.00%	Dipertahankan
13.	Kepuasan Pasien	99.70%	99.89%	99.79%	≥ 76,61	99.79%	Dipertahankan

3.1.1 Analisis Capaian Indikator Mutu Nasional

1. Angka Kepatuhan Kebersihan Tangan



Gambar 3.1 Grafik Capaian Indikator Angka Kepatuhan Kebersihan Tangan RS Prima Husada Malang bulan Januari-Maret tahun 2026

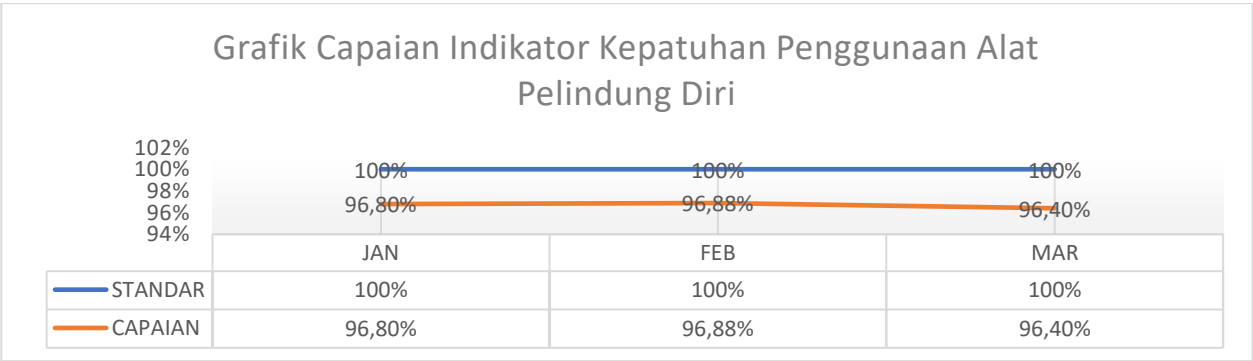
Analisis:

Pada Triwulan I, angka kepatuhan kebersihan tangan di RS Prima Husada Malang mencapai **85,39%** pada akhir periode pengukuran. Berdasarkan hasil monitoring selama Januari hingga Maret, capaian kepatuhan kebersihan tangan menunjukkan fluktuasi dengan kecenderungan mengalami penurunan pada bulan Maret dibandingkan bulan sebelumnya sebesar **0,48%**. Meskipun secara keseluruhan capaian pada triwulan ini masih memenuhi standar yang telah ditetapkan rumah sakit, hasil tersebut berada relatif dekat dengan batas standar sehingga perlu menjadi perhatian untuk mencegah terjadinya penurunan lebih lanjut.

Hasil ini menunjukkan bahwa implementasi kebersihan tangan oleh petugas telah berjalan cukup baik, namun konsistensi kepatuhan masih perlu ditingkatkan. Oleh karena itu, diperlukan upaya berkelanjutan melalui penguatan edukasi dan sosialisasi terkait kebersihan tangan, peningkatan kegiatan monitoring dan observasi kepatuhan secara berkala, pemberian umpan balik kepada unit dan petugas, serta optimalisasi peran IPCN dalam supervisi dan pembinaan. Studi *Quality Improvement* yang dilakukan oleh Sitohang dkk. (2025) menunjukkan bahwa edukasi tenaga kesehatan, monitoring dan supervisi IPCN, serta simulasi langsung **5 Moments Hand Hygiene** efektif dalam meningkatkan kepatuhan kebersihan tangan di rumah sakit. Dengan pelaksanaan strategi tersebut secara konsisten, diharapkan capaian kepatuhan kebersihan tangan pada triwulan berikutnya dapat meningkat dan dipertahankan di atas target yang ditetapkan.

2. Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD)

Gambar 2. Grafik Capaian Indikator Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri



Analisis:

Pada Triwulan I, kepatuhan penggunaan alat pelindung diri (APD) di RS Prima Husada Malang mencapai **96,40%** pada akhir periode pengukuran. Berdasarkan hasil monitoring selama Januari hingga Maret, capaian kepatuhan APD menunjukkan fluktuasi dengan penurunan pada bulan Maret sebesar **0,48%** dibandingkan bulan Februari. Meskipun capaian tersebut tergolong tinggi, masih terdapat **gap sebesar 3,60%** dari standar minimal yang ditetapkan rumah sakit yaitu **100%**. Beberapa unit telah menunjukkan kepatuhan yang sangat baik dengan capaian **100%**, yaitu IGD, HCU, ICU, PICU, IKO, IFRS, Pengadaan Farmasi, Instalasi Laboratorium, Instalasi Radiologi, IRNA 2A, IRNA 2C, IRNA 3A, IRNA 3C, IRNA 4A, IRNA 6A, Maternitas, Neonatologi, dan Perinatologi. Namun demikian, masih terdapat variasi capaian antarunit, dengan kepatuhan terendah berada di **IRNA 8A sebesar 75,83%**.

Hasil ini menunjukkan bahwa kepatuhan penggunaan APD secara umum sudah baik, tetapi konsistensi penerapan di seluruh unit masih perlu ditingkatkan. Upaya perbaikan dapat dilakukan melalui penguatan edukasi terkait penggunaan APD yang sesuai standar, peningkatan monitoring dan supervisi rutin, pemberian umpan balik kepada unit dengan capaian rendah, serta evaluasi terhadap kendala yang dihadapi petugas dalam penggunaan APD. Dengan tindak lanjut yang berkesinambungan, diharapkan kepatuhan penggunaan APD pada triwulan berikutnya dapat mencapai target yang telah ditetapkan.

Tabel 3.2 PDSA Capaian Kepatuhan Penggunaan APD pada Triwulan I Tahun 2026

Problem	Pada Triwulan I, kepatuhan penggunaan alat pelindung diri (APD) di RS Prima Husada Malang mencapai 96,40% pada akhir periode pengukuran. Berdasarkan hasil monitoring selama Januari hingga Maret, capaian kepatuhan APD menunjukkan fluktuasi dengan penurunan pada bulan Maret sebesar 0,48% dibandingkan bulan Februari. Meskipun capaian tersebut tergolong tinggi, masih terdapat gap sebesar 3,60% dari standar minimal yang ditetapkan rumah sakit yaitu 100% . Masalah yang ditemukan adalah masih ditemukan ketidaktepatan penggunaan APD baik yang tidak lengkap maupun berlebihan, pemahaman staf mengenai indikasi penggunaan APD masih belum merata, kebiasaan kerja lama masih memengaruhi perilaku penggunaan APD sehingga praktik belum konsisten, dan monitoring dan audit kepatuhan belum dilakukan secara merata.
Plan	Mengupayakan peningkatan kepatuhan penggunaan APD sehingga mencapai standar minimal (100%) dengan mengingatkan petugas yang memakai APD berlebihan, mengevaluasi penggunaan stok APD, memberikan edukasi, dan melakukan supervisi terkait ketersediaan dan penggunaan APD.
Do	1. Pengawasan penggunaan APD 2. Edukasi penggunaan APD
Study	Capaian target pada akhir periode pengukuran triwulan ini masih belum memenuhi standar minimal (100%) sebesar 96.40%. Terjadinya penurunan dari bulan sebelumnya menunjukkan adanya penurunan perilaku penggunaan APD, menurunnya kesadaran staf, atau kurangnya pengaruh dari pengawasan dan edukasi langsung yang dilakukan bulan sebelumnya.
Action	1. Mengingatkan kembali petugas yang memakai APD berlebihan terkait transmisi penyebaran penyakitnya. 2. Melakukan evaluasi penggunaan stok APD pada petugas koordinasi dengan pengadaan farmasi. 3. Memberikan proses pembelajaran kepala unit dan IPCLN yang anggotanya ketahuan tidak patuh dalam pemakaian APD. (mendata ketidakpatuhan pemakaian APD, konfirmasi Karu dan SDM). 4. Menanamkan kesadaran pada pribadi masing-masing petugas bahwa pemakaian APD yang benar ini penting. 5. Melakukan monitoring pelaksanaan audit kepatuhan penggunaan APD yang sesuai. 6. Melakukan supervise terkait ketersediaan dan kesesuaian penggunaan APD. 7. Memberikan edukasi pemakaian APD yang tepat antar staf dibantu oleh IPCLN dan anggota Komite PPI lainnya.

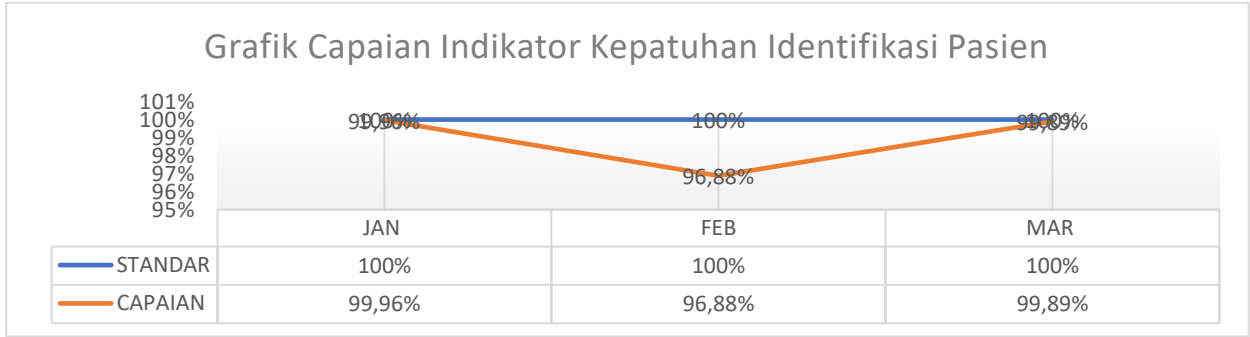
Tabel 3.3 Rencana Tindak Lanjut

N o	Rencana Kegiatan	Tujuan	Sasaran	Strategik	Pelaksana	Waktu
1	Peningkatan Kepatuhan	Meningkatkan kepatuhan	Seluruh tenaga	Sosialisasi ulang standar	• Komite PPI, IPCN	1 bulan

	penggunaa n APD sesuai standar	penggunaan APD sesuai standar	kesehata n	penggunaa n APD sesuai indikasi		
2	Peningkata n pemahama n staf terkait APD	Meningkatkan pemahaman staf tentang penggunaan APD yang tepat	Perawat dan tenaga kesehata n	Edukasi dan refresh training terkait indikasi dan jenis APD	• IPCN • Kepala Ruanga n	1-2 bulan
3	Peningkata n Konsistensi penggunaa n APD yang benar	Meningkatkan konsistensi penggunaan APD	Seluruh staf unit pelayana n	Audit kepatuhan penggunaa n APD secara berkala dan pemberian feedback	• Komite PPI	Setiap bulan
4	Menurunka n kebiasaan penggunaa n APD yang tidak sesuai	Mengurangi penggunaan APD yang tidak sesuai (kurang/berlebiha n)	Tenaga kesehata n di unit pelayana n	Supervisi langsung di ruangan dan penguatan budaya keselamata n kerja	• Kepala Ruanga n • IPCN • Komite PMKP	Berkelanjuta n
5	Kontroling ketersediaa n APD	Mengoptimalkan ketersediaan dan penggunaan APD	Unit pelayana n	Monitoring penggunaa n dan stok APD serta koordinasi dengan instalasi farmasi	• Komite PPI • Farmasi	Setiap bulan

3. Kepatuhan Identifikasi Pasien

Gambar 3. Grafik Capaian Indikator Kepatuhan Identifikasi Pasien



Analisis:

Pada Triwulan I tahun 2026, kepatuhan identifikasi pasien di RS Prima Husada Malang mencapai **99,89%** pada akhir periode pengukuran. Berdasarkan hasil monitoring selama Januari hingga Maret, capaian kepatuhan identifikasi pasien menunjukkan tren yang baik dengan peningkatan pada bulan Maret sebesar **3,01%** dibandingkan bulan sebelumnya. Capaian ini menunjukkan

bahwa sebagian besar petugas telah melaksanakan proses identifikasi pasien sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Meskipun capaian tersebut sangat tinggi, masih terdapat **gap sebesar 0,11%** dari standar minimal yang ditetapkan rumah sakit yaitu **100%**. Hal ini menunjukkan bahwa masih ditemukan ketidakpatuhan dalam pelaksanaan identifikasi pasien, meskipun jumlahnya sangat kecil. Mengingat identifikasi pasien merupakan salah satu sasaran keselamatan pasien yang sangat penting, setiap kejadian ketidakpatuhan tetap perlu menjadi perhatian karena berpotensi menimbulkan risiko kesalahan pelayanan.

Untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian yang telah diperoleh, diperlukan upaya berkelanjutan melalui penguatan edukasi kepada petugas, monitoring dan audit kepatuhan secara rutin, pemberian umpan balik hasil monitoring kepada unit terkait, serta penguatan budaya keselamatan pasien dalam setiap proses pelayanan. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan kepatuhan identifikasi pasien pada triwulan berikutnya dapat mencapai target **100%** dan dipertahankan secara konsisten.

Tabel 3.4 PDSA Capaian Kepatuhan Identifikasi Pasien pada Triwulan I tahun 2026

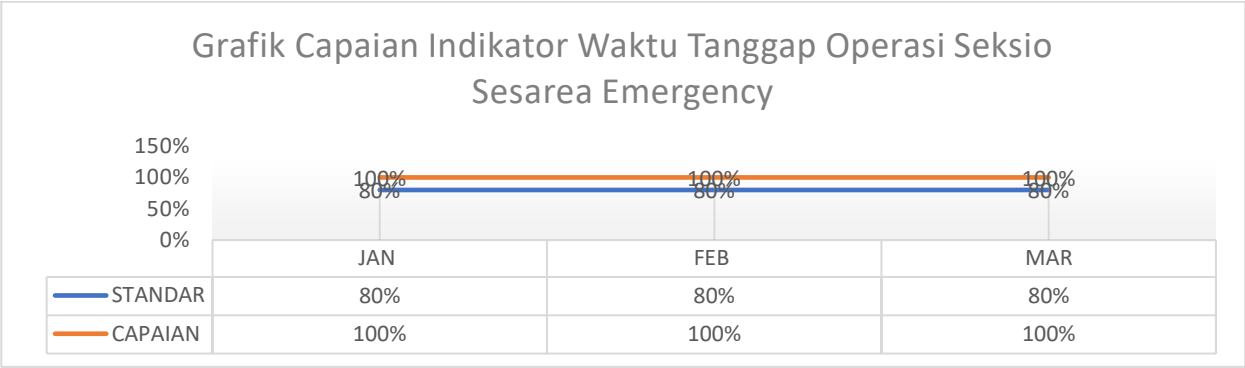
Problem	Pada Triwulan I tahun 2026, kepatuhan identifikasi pasien di RS Prima Husada Malang mencapai 99,89% pada akhir periode pengukuran. Berdasarkan hasil monitoring selama Januari hingga Maret, capaian kepatuhan identifikasi pasien menunjukkan tren yang baik dengan peningkatan pada bulan Maret sebesar 3,01% dibandingkan bulan sebelumnya. Capaian ini menunjukkan bahwa sebagian besar petugas telah melaksanakan proses identifikasi pasien sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Plan	Berdasarkan hasil monitoring indikator mutu kepatuhan identifikasi pasien di unit pelayanan, ditemukan bahwa kepatuhan petugas dalam melakukan identifikasi pasien belum sepenuhnya sesuai dengan standar yang ditetapkan rumah. Beberapa temuan antara lain petugas tidak melakukan identifikasi menggunakan minimal dua identitas pasien (nama lengkap dan tanggal lahir / nomor rekam medis) sebelum tindakan, pemberian obat, maupun pengambilan spesimen. Selain itu masih terdapat petugas yang tidak melakukan konfirmasi ulang kepada pasien. Oleh karena itu direncanakan upaya perbaikan berupa sosialisasi ulang SPO identifikasi pasien, peningkatan pengawasan oleh kepala unit, serta penguatan budaya keselamatan pasien.
Do	Komite PMKP bersama kepala unit dan ruangan melakukan sosialisasi kembali terkait standar identifikasi pasien kepada seluruh petugas pelayanan. Diingatkan mengenai pentingnya identifikasi pasien sebelum tindakan, pemberian obat, pengambilan sampel laboratorium, maupun tindakan lainnya. Selain itu dilakukan monitoring dan audit kepatuhan identifikasi pasien secara berkala serta pengawasan langsung oleh kepala unit.
Study	Setelah dilakukan intervensi, dilakukan evaluasi melalui audit kepatuhan identifikasi pasien pada periode monitoring berikutnya. Hasil evaluasi menunjukkan adanya peningkatan kepatuhan petugas dalam melakukan identifikasi pasien, namun masih ditemukan beberapa petugas yang belum konsisten melakukan identifikasi terutama pada kondisi pelayanan yang sibuk atau pada pasien yang sudah dikenal oleh petugas.
Action	Peningkatan kepatuhan identifikasi pasien

Tabel 3.5 Rencana Tindak Lanjut

N o	Rencana Kegiatan	Tujuan	Sasaran	Strategik	Pelaksana	Waktu
--------	---------------------	--------	---------	-----------	-----------	-------

1	Peningkatan kepatuhan identifikasi pasien	Meningkatkan kepatuhan identifikasi pasien	Seluruh tenaga kesehatan	Rumah sakit akan terus melakukan monitoring dan evaluasi kepatuhan identifikasi pasien secara berkala. Kepala ruangan diminta memberikan pengawasan secara langsung serta memberikan umpan balik kepada petugas yang belum patuh mengidentifikasi pasien menggunakan minimal dua identitas pasien (nama lengkap dan tanggal lahir/nomor rekam medis). Edukasi terkait keselamatan pasien akan terus dilakukan secara berkelanjutan agar kepatuhan identifikasi pasien dapat mencapai dan mempertahankan standar yang telah ditetapkan oleh rumah sakit.	• Kepala ruangan	1 bulan
---	---	--	--------------------------	---	------------------	---------

4. Waktu Tanggap Operasi Seksio Sesarea Emergency
Gambar 4. Grafik Capaian Indikator Waktu Tanggap Operasi Seksio Sesarea Emergency



Analisis:

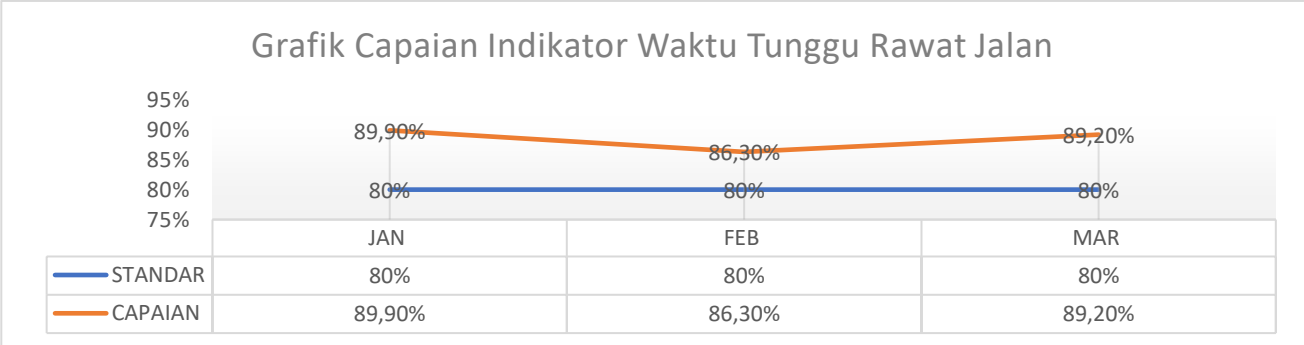
Pada Triwulan I tahun 2026, waktu tanggap operasi seksio sesarea (SC) emergensi ≤ 30 menit di RS Prima Husada Malang mencapai **100%** pada akhir periode pengukuran. Seluruh pasien yang memerlukan tindakan SC emergensi selama periode tersebut mendapatkan respons dan pelaksanaan operasi dalam waktu ≤ 30 menit, sehingga capaian ini telah melampaui standar minimal yang ditetapkan yaitu **80%**.

Keberhasilan pencapaian indikator ini menunjukkan bahwa koordinasi dan kerja sama antarunit terkait telah berjalan dengan baik, khususnya antara Instalasi Gawat Darurat, Unit Maternitas, dan Instalasi Kamar Operasi. Selain itu, dukungan manajemen rumah sakit dalam penyediaan sumber daya manusia, sarana, dan prasarana yang memadai turut berperan dalam memastikan pelayanan SC emergensi dapat dilakukan secara cepat dan tepat waktu.

Capaian yang optimal ini perlu dipertahankan melalui monitoring berkala, penguatan koordinasi lintas unit, serta kesiapsiagaan tim dalam menangani kasus kegawatdaruratan obstetri. Konsistensi dalam mempertahankan waktu tanggap SC emergensi sangat penting untuk meminimalkan risiko komplikasi serta meningkatkan keselamatan ibu dan bayi.

5. Waktu Tunggu Rawat Jalan

Gambar 5. Grafik Capaian Indikator Waktu Tunggu Rawat Jalan



Analisis:

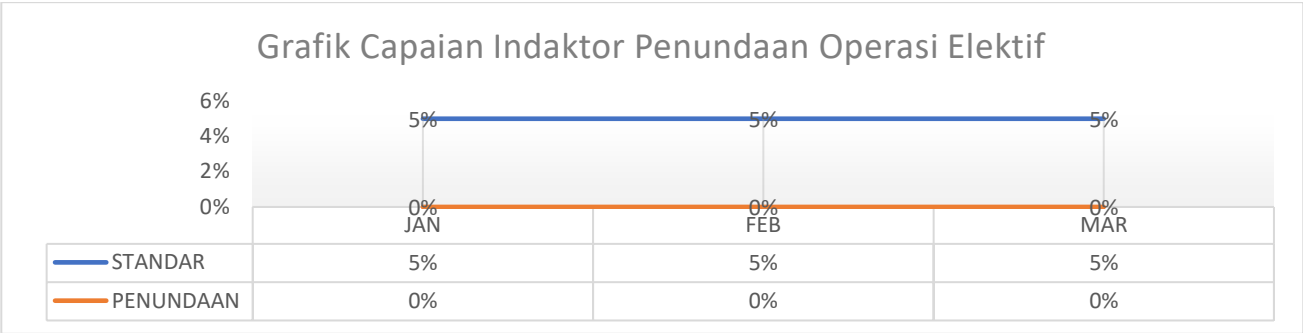
Pada Triwulan I tahun 2026, capaian waktu tunggu pelayanan rawat jalan ≤ 60 menit di RS Prima Husada Malang mencapai **89,20%** pada akhir periode pengukuran. Berdasarkan hasil monitoring selama Januari hingga Maret, capaian indikator ini menunjukkan tren yang positif dengan peningkatan sebesar **2,90%** dibandingkan bulan sebelumnya. Hasil tersebut telah memenuhi standar minimal yang ditetapkan rumah sakit yaitu **$\geq 80\%$** .

Meskipun telah memenuhi target, capaian belum mencapai kondisi optimal karena masih terdapat pasien yang mengalami waktu tunggu lebih dari 60 menit. Beberapa faktor yang berkontribusi terhadap kondisi tersebut antara lain penumpukan pasien pada jam-jam tertentu saat pendaftaran serta keterlambatan kedatangan dokter sesuai jadwal praktik. Kondisi ini dapat memengaruhi kelancaran alur pelayanan dan kepuasan pasien.

Untuk meningkatkan capaian pada triwulan berikutnya, diperlukan upaya perbaikan melalui optimalisasi sistem antrean dan pendaftaran online, pengaturan distribusi jadwal pelayanan yang lebih efektif, serta penyesuaian dan pemantauan kepatuhan jadwal praktik dokter. Selain itu, monitoring dan evaluasi secara berkala perlu terus dilakukan untuk mengidentifikasi hambatan pelayanan dan memastikan waktu tunggu rawat jalan tetap berada di atas standar yang ditetapkan serta dapat ditingkatkan mendekati target optimal.

6. Penundaan Operasi Elektif

Gambar 6. Grafik capaian Indikator Penundaan Operasi Elektif



Analisis:

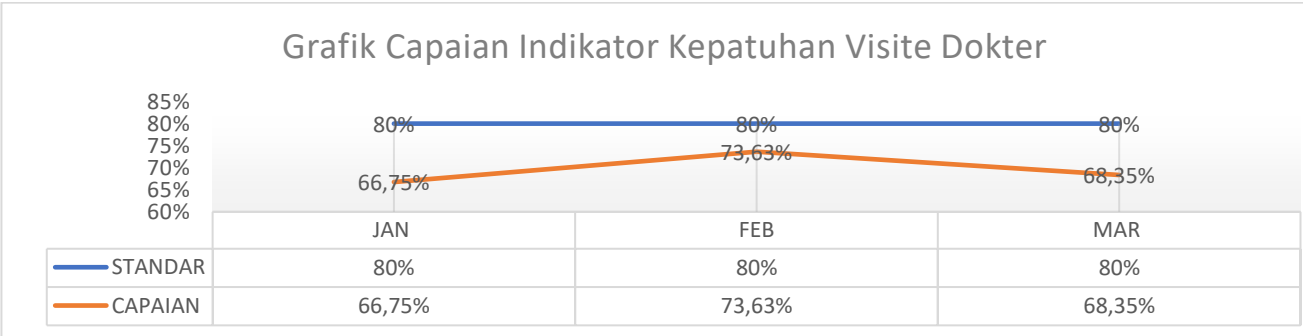
Pada Triwulan I tahun 2026, indikator penundaan operasi elektif di RS Prima Husada Malang mencapai **0%** pada akhir periode pengukuran. Capaian ini telah memenuhi bahkan melampaui standar yang ditetapkan yaitu **≤5%**, yang menunjukkan bahwa seluruh operasi elektif yang telah dijadwalkan dapat dilaksanakan sesuai rencana tanpa terjadi penundaan.

Keberhasilan pencapaian indikator ini menunjukkan adanya koordinasi dan kerja sama yang baik antara Instalasi Rawat Jalan, Instalasi Rawat Inap, dan Instalasi Kamar Operasi, serta dukungan manajemen rumah sakit dalam memastikan kelancaran proses pelayanan bedah. Selain itu, perencanaan yang matang terkait ketersediaan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, alat kesehatan, serta pengelolaan jadwal ruang operasi turut berkontribusi dalam mencegah terjadinya penundaan operasi elektif.

Capaian yang sangat baik ini perlu dipertahankan melalui monitoring dan evaluasi berkala terhadap proses penjadwalan operasi, kesiapan pasien, ketersediaan SDM, serta kesiapan alat dan ruang operasi. Dengan mempertahankan sinergi dan koordinasi antarunit, diharapkan indikator penundaan operasi elektif dapat terus berada pada tingkat optimal sehingga mutu pelayanan dan keselamatan pasien tetap terjaga.

7. Kepatuhan Waktu Visite Dokter

Gambar 7. Grafik Capaian Indikator Kepatuhan Visite Dokter



Analisis:

Pada Triwulan I tahun 2026, indikator kepatuhan waktu visite dokter di RS Prima Husada Malang mencapai **68,35%** pada akhir periode pengukuran. Berdasarkan hasil monitoring selama Januari hingga Maret, capaian indikator ini menunjukkan penurunan sebesar **5,28%** dibandingkan bulan sebelumnya. Hasil tersebut belum memenuhi standar minimal yang ditetapkan rumah sakit yaitu **≥80%**, sehingga masih terdapat gap sebesar **11,65%** yang perlu menjadi perhatian.

Capaian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan visite dokter belum dilakukan secara konsisten sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Ketidakpatuhan waktu visite dapat memengaruhi kontinuitas pelayanan, keterlambatan pengambilan keputusan klinis, serta kepuasan pasien terhadap pelayanan yang diberikan.

Untuk meningkatkan capaian indikator pada triwulan berikutnya, diperlukan upaya perbaikan melalui penguatan komitmen dokter terhadap jadwal visite yang telah ditetapkan, monitoring dan evaluasi kepatuhan secara berkala, pemberian umpan balik kepada dokter atau unit terkait, serta koordinasi yang lebih efektif antara dokter penanggung jawab pasien dan unit pelayanan. Selain itu, perlu dilakukan identifikasi lebih lanjut terhadap faktor-faktor yang menyebabkan keterlambatan visite sehingga dapat disusun langkah perbaikan yang tepat dan berkelanjutan. Dengan upaya tersebut, diharapkan kepatuhan waktu visite dokter dapat meningkat dan mencapai standar yang telah ditetapkan.

Tabel 3.6 PDSA Capaian Kepatuhan Waktu Visite Dokter

Problem	Capaian kepatuhan waktu visite dokter sebesar 68.35%, masih belum memenuhi standar yang ditetapkan dikarenakan ada beberapa dokter yang melakukan visite di atas jam 14.00. Hal tersebut memang tidak mencapai standart jika di nilai waktu visite jam 07.00 hingga jam 14.00 karena dokter memiliki jadwal praktik ditempat lain tetapi DPJP telah melakukan visite 1x setiap harinya di jam yang sudah disepakati atau menyesuaikan jadwal praktik di rumah sakit Prima Husada Malang.
Plan	Mengupayakan peningkatan kepatuhan waktu visite dokter untuk memenuhi standar minimal (≥80%) dengan penguatan komunikasi dengan DPJP dalam rangka komitmen visite sesuai jam yang disepakati.
Do	- Penguatan komunikasi dengan DPJP dalam rangka komitmen visite sesuai jam yang disepakati - Koordinasi perawat dengan DPJP terkait jadwal visite - Monitoring pelaksanaan visite oleh manajemen/unit terkait
Study	Berdasarkan grafik capaian indikator kepatuhan visite dokter dapat diketahui bahwa capaian di bulan Maret yaitu 68.35%. Hal tersebut memang tidak mencapai standart jika di nilai waktu visite jam 07.00 hingga jam 14.00 karena dokter memiliki jadwal praktik ditempat lain tetapi DPJP telah melakukan visite 1x setiap harinya di jam yang sudah disepakati atau menyesuaikan jadwal praktik di rumah sakit Prima Husada Malang.
Action	Penguatan komunikasi dengan DPJP

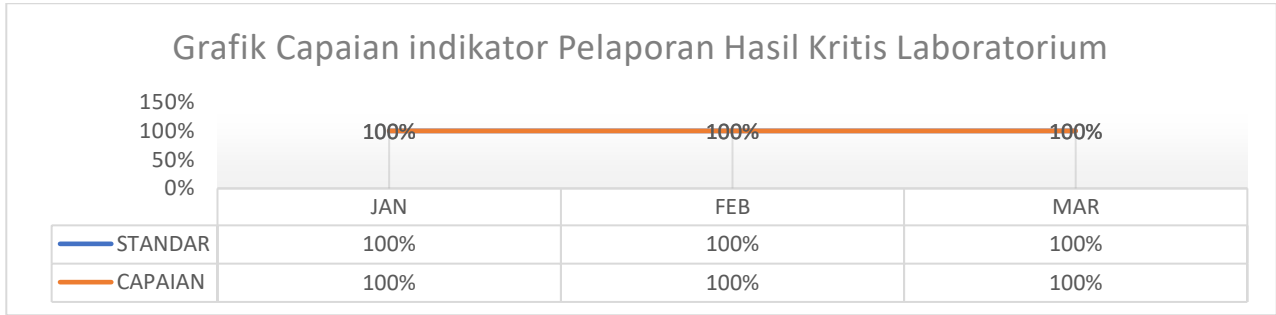
Tabel 3.7 Rencana Tindak Lanjut

No	Rencana Kegiatan	Tujuan	Sasaran	Strategik	Pelaksana	Waktu
1	Penguatan komunikasi dengan DPJP	Meningkatkan kepatuhan waktu visite dokter	DPJP yang tidak patuh waktu visite	Rumah sakit akan terus melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kepatuhan waktu visite dokter secara berkala. Koordinasi dengan Komite Medik akan terus dilakukan untuk meningkatkan kedisiplinan waktu visite. Selain itu, kepala ruang	• Manajemen RS	1 bulan

				rawat inap diminta untuk melakukan pengingat dan pelaporan apabila terdapat dokter yang belum melakukan visite sesuai waktu yang telah ditentukan. Upaya ini dilakukan untuk meningkatkan mutu pelayanan serta kepuasan pasien selama menjalani perawatan di rumah sakit.		
--	--	--	--	---	--	--

8. Pelaporan Hasil Kritis Laboratorium

Gambar 8. Grafik Capaian Indikator Pelaporan Hasil Kritis Laboratorium



Analisis:

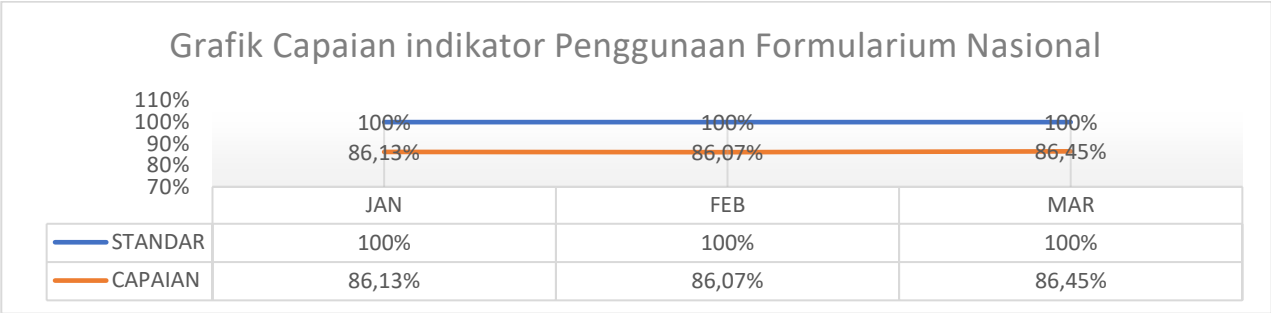
Pada Triwulan I tahun 2026, capaian indikator pelaporan hasil kritis laboratorium di RS Prima Husada Malang mencapai **100%** dan telah memenuhi standar yang ditetapkan yaitu **100%**. Hasil ini menunjukkan bahwa seluruh hasil pemeriksaan laboratorium yang termasuk kategori kritis telah dilaporkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, capaian tersebut berhasil dipertahankan secara konsisten selama **tiga bulan berturut-turut**, yang mencerminkan efektivitas pelaksanaan proses pelaporan hasil kritis di rumah sakit.

Keberhasilan ini menunjukkan adanya komitmen yang baik dari petugas laboratorium dan unit terkait dalam menjalankan proses komunikasi hasil kritis secara tepat dan cepat guna mendukung keselamatan pasien. Pelaporan hasil kritis yang tepat waktu sangat penting untuk memastikan tenaga medis dapat segera mengambil tindakan yang diperlukan terhadap kondisi pasien.

Untuk mempertahankan capaian tersebut, perlu dilakukan upaya berkelanjutan melalui sosialisasi kebijakan dan SPO pelaporan hasil kritis kepada seluruh petugas terkait, penguatan implementasi alur komunikasi hasil kritis, serta peningkatan kesadaran bahwa pelaporan hasil kritis merupakan bagian penting dari budaya keselamatan pasien. Dengan konsistensi pelaksanaan kegiatan tersebut, diharapkan capaian indikator dapat terus dipertahankan pada triwulan berikutnya.

9. Kepatuhan Penggunaan Formularium Nasional

Gambar 9. Grafik Capaian Kepatuhan Penggunaan Formularium Nasional



Analisis:

Pada bulan Maret tahun 2026, capaian indikator pelaporan hasil kritis laboratorium sebesar 86.45%. Capaian ini mengalami peningkatan dari bulan sebelumnya sebesar 0.38%. Namun, meskipun mengalami peningkatan, capaian ini belum memenuhi standar minimal yang ditetapkan (100%). Oleh karena itu, upaya perbaikan diperlukan agar dapat memenuhi standar yang telah ditetapkan.

Tabel 3.7 PDSA Capaian Kepatuhan Penggunaan Formularium Nasional

Problem	Capaian kepatuhan penggunaan formularium nasional sebesar 86.45%. Hasil ini belum memenuhi standar yang telah ditetapkan yakni 100%. Berdasarkan hasil monitoring indikator mutu kepatuhan penggunaan Formularium Nasional (Fornas), masih ditemukan penggunaan obat yang tidak sesuai dengan daftar Formularium Nasional sehingga capaian indikator belum memenuhi standar yang telah ditetapkan oleh rumah sakit. Beberapa faktor yang mempengaruhi antara lain masih kurangnya pemahaman dokter terhadap daftar obat dalam Formularium Nasional, belum optimalnya sosialisasi terkait pembaruan Fornas, serta belum adanya pengingat pada sistem peresepan apabila obat yang diresepkan tidak termasuk dalam Fornas.
Plan	Meningkatkan capaian kepatuhan penggunaan formularium nasional agar memenuhi standar yang ditetapkan dengan upaya perbaikan melalui sosialisasi penggunaan Formularium Nasional kepada tenaga medis, penyediaan daftar Fornas terbaru di setiap unit pelayanan, peningkatan peran instalasi farmasi dalam melakukan skrining resep, serta pelaksanaan audit resep secara berkala untuk memantau kepatuhan penggunaan Fornas.
Do	Upaya perbaikan dilakukan dengan melaksanakan sosialisasi kepada dokter dan tenaga kesehatan mengenai pentingnya penggunaan obat sesuai Formularium Nasional. Selain itu instalasi farmasi mendistribusikan atau menyediakan daftar Formularium Nasional terbaru yang dapat diakses oleh tenaga medis di unit pelayanan. Petugas farmasi juga melakukan skrining terhadap resep yang masuk untuk memastikan kesesuaian obat dengan Formularium Nasional serta melakukan konfirmasi kepada dokter apabila ditemukan resep yang tidak sesuai. Tim PMKP bersama instalasi farmasi melakukan pengumpulan dan monitoring data penggunaan obat sesuai Fornas secara berkala.
Study	Berdasarkan grafik, diketahui bahwa capaian kepatuhan penggunaan formularium nasional pada bulan Maret mengalami peningkatan dari bulan sebelumnya, namun masih belum memenuhi standar yang ditetapkan. Hal tersebut dikarenakan masih kurangnya pemahaman dokter terhadap daftar obat dalam Formularium Nasional, belum optimalnya sosialisasi terkait pembaruan Fornas, serta belum adanya pengingat pada sistem peresepan apabila obat yang diresepkan tidak termasuk dalam Fornas.
Action	Sosialisasi kepada dokter dan tenaga kesehatan mengenai pentingnya penggunaan obat sesuai Formularium Nasional

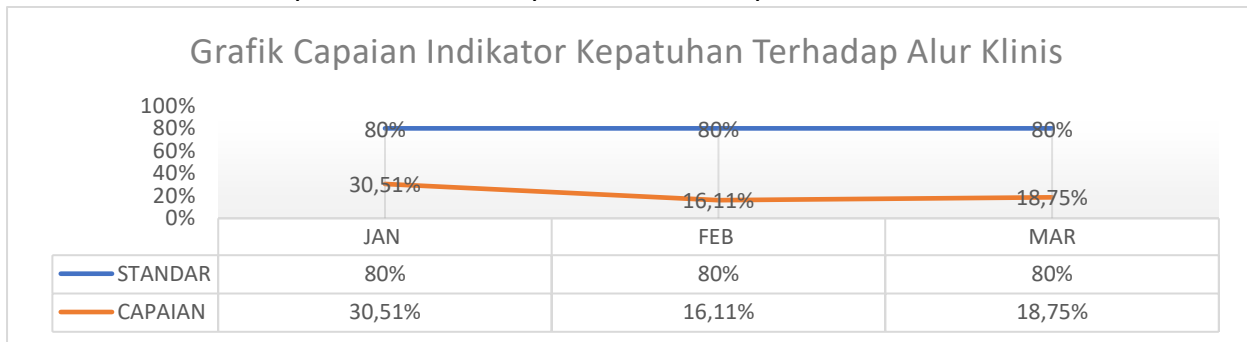
Tabel 3.8 Rencana Tindak Lanjut

No	Rencana Kegiatan	Tujuan	Sasaran	Strategik	Pelaksana	Waktu
----	------------------	--------	---------	-----------	-----------	-------

1	Sosialisasi terkait pembaruan Fornas	Meningkatkan kepatuhan penggunaan formularium nasional	Seluruh dokter dan tenaga kesehatan	Berdasarkan hasil evaluasi, apabila capaian indikator masih belum memenuhi standar maka akan dilakukan tindak lanjut berupa sosialisasi ulang kepada tenaga medis, pembinaan kepada unit dengan tingkat kepatuhan rendah, serta penguatan proses skrining resep oleh instalasi farmasi. Selain itu rumah sakit juga dapat mengoptimalkan sistem informasi rumah sakit dengan menambahkan fitur pengingat atau notifikasi apabila obat yang diresepkan tidak termasuk dalam Formularium Nasional. Monitoring dan evaluasi terhadap indikator ini akan terus dilakukan secara berkala dan hasilnya dilaporkan kepada Komite PMKP serta manajemen rumah sakit sebagai dasar perbaikan mutu pelayanan	Manajemen RS	1 bulan
---	--------------------------------------	--	-------------------------------------	--	--	---------

10. Kepatuhan Terhadap Alur Klinis (Clinical Pathway)

Gambar 10. Grafik Capaian Indikator Kepatuhan Terhadap Alur Klinis



Analisis:

Pada Triwulan I tahun 2026, capaian indikator kepatuhan terhadap alur klinis (*clinical pathway*) di RS Prima Husada Malang mencapai **18,75%** pada akhir periode pengukuran. Berdasarkan hasil monitoring selama Januari hingga Maret, capaian indikator ini menunjukkan peningkatan sebesar **2,64%** dibandingkan bulan sebelumnya. Meskipun terdapat tren perbaikan, capaian tersebut masih jauh di bawah standar yang ditetapkan yaitu **80%**, sehingga masih terdapat **gap sebesar 61,25%**.

Rendahnya kepatuhan terhadap *clinical pathway* menunjukkan bahwa implementasi alur klinis dalam pelayanan pasien belum berjalan secara optimal dan konsisten. Kondisi ini dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kurangnya pemahaman petugas terhadap penggunaan *clinical pathway*, ketidaklengkapan dokumentasi, beban kerja yang tinggi, maupun belum optimalnya monitoring dan evaluasi pelaksanaannya di unit pelayanan.

Capaian ini menjadi perhatian penting karena *clinical pathway* merupakan salah satu instrumen untuk memastikan pelayanan pasien diberikan secara terstandar, efektif, efisien, dan berbasis bukti. Oleh karena itu, diperlukan upaya perbaikan yang berkelanjutan melalui penguatan sosialisasi dan edukasi kepada tenaga kesehatan, peningkatan monitoring dan audit kepatuhan, pemberian umpan balik kepada unit terkait, serta evaluasi terhadap kendala yang dihadapi dalam implementasi *clinical pathway*. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan kepatuhan terhadap alur klinis dapat terus meningkat sehingga gap terhadap standar semakin berkurang pada triwulan berikutnya.

Tabel 3.9 PDSA Kepatuhan terhadap Alur Klinis

Problem	Capaian kepatuhan alur klinis pada periode akhir pengukuran triwulan I sebesar 18.75%, mengalami peningkatan dari bulan sebelumnya sebesar 2.64%. Namun, capaian ini masih jauh dari standar yang ditetapkan (80%). Hal ini menunjukkan bahwa tenaga medis belum sepenuhnya patuh dalam menggunakan atau mengisi dokumen alur klinis (clinical pathway) pada pasien dengan diagnosis yang telah ditetapkan. Beberapa faktor penyebab yang teridentifikasi antara lain kurangnya pemahaman petugas mengenai penggunaan alur klinis, keterbatasan waktu dalam pengisian dokumen, serta kurangnya monitoring dari unit terkait.
Plan	Meningkatkan capaian kepatuhan terhadap alur klinis agar memenuhi standar yang ditetapkan (80%) dengan sosialisasi kembali mengenai penggunaan alur klinis, peningkatan monitoring kepatuhan pengisian oleh kepala ruangan atau PJ Mutu Unit, serta koordinasi dengan Komite Medik dan DPJP.
Do	Tim PMKP bersama Komite Medik melakukan sosialisasi dan edukasi kepada dokter dan tenaga kesehatan terkait pentingnya penggunaan alur klinis dalam pelayanan pasien. Selain itu dilakukan pengingat kepada DPJP dan petugas terkait untuk mengisi alur klinis sesuai diagnosis yang telah ditentukan. Kepala unit rawat inap juga diminta melakukan monitoring kelengkapan pengisian alur klinis pada rekam medis pasien.
Study	Capaian kepatuhan terhadap alur klinis pada bulan Maret sebesar 18.75%. Sementara pada bulan Februari mencapai 16.11% yang berarti mengalami peningkatan sebesar 2.64%. Hal tersebut karena tenaga medis belum sepenuhnya

	patuh dalam menggunakan atau mengisi dokumen alur klinis (clinical pathway) pada pasien dengan diagnosis yang telah ditetapkan.
Action	Sosialisasi terkait pengisian dokumen alur klinis (clinical pathway)

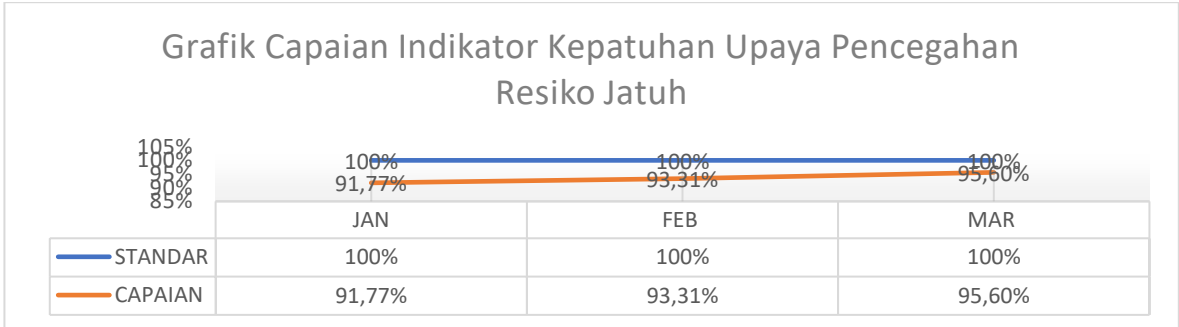
Tabel 3.10 Rencana Tindak Lanjut

No	Rencana Kegiatan	Tujuan	Sasaran	Strategik	Pelaksana	Waktu
1	Sosialisasi terkait pengisian dokumen alur klinis (<i>clinical pathway</i>)	Meningkatkan kepatuhan pengisian dokumen alur klinis	Seluruh tenaga medis pelayanan	Rumah sakit akan terus melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap kepatuhan penggunaan alur klinis. Komite Medik bersama Komite PMKP akan melakukan penguatan implementasi clinical pathway kepada DPJP serta melakukan supervisi terhadap pengisian dokumen alur klinis dalam rekam medis pasien. Selain itu, akan dilakukan evaluasi berkala serta pemberian umpan balik kepada unit pelayanan untuk meningkatkan kepatuhan terhadap alur klinis sehingga capaian indikator dapat mencapai	Manajemen RS	1 bulan

				standar yang ditetapkan.		
--	--	--	--	--------------------------	--	--

11. Kepatuhan Upaya Pencegahan Resiko Jatuh

Gambar 11. Grafik Capaian Indikator Kepatuhan Upaya Pencegahan Resiko Jatuh



Analisis:

Pada Triwulan I tahun 2026, capaian indikator kepatuhan upaya pencegahan risiko pasien jatuh di RS Prima Husada Malang mencapai **95,60%** pada akhir periode pengukuran. Berdasarkan hasil monitoring selama Januari hingga Maret, capaian indikator ini menunjukkan peningkatan sebesar **2,29%** dibandingkan bulan sebelumnya. Hal ini menunjukkan adanya perbaikan dalam pelaksanaan upaya pencegahan risiko pasien jatuh oleh petugas di unit pelayanan.

Meskipun mengalami peningkatan, capaian tersebut masih belum memenuhi standar yang ditetapkan rumah sakit yaitu **100%**, sehingga masih terdapat **gap sebesar 4,40%**. Kondisi ini menunjukkan bahwa masih ditemukan ketidakpatuhan dalam penerapan langkah-langkah pencegahan risiko pasien jatuh yang berpotensi meningkatkan risiko terjadinya insiden keselamatan pasien.

Untuk meningkatkan capaian indikator pada triwulan berikutnya, diperlukan upaya perbaikan melalui penguatan edukasi kepada petugas mengenai pencegahan risiko pasien jatuh, peningkatan kepatuhan dalam melakukan asesmen dan dokumentasi risiko jatuh, monitoring serta audit kepatuhan secara berkala, dan pemberian umpan balik kepada unit dengan capaian yang belum optimal. Selain itu, perlu dilakukan evaluasi terhadap faktor-faktor yang menyebabkan ketidakpatuhan sehingga dapat ditetapkan tindakan perbaikan yang lebih efektif. Dengan upaya tersebut, diharapkan kepatuhan upaya pencegahan risiko pasien jatuh dapat terus meningkat dan mencapai standar yang telah ditetapkan.

Tabel 3.11 PDSA Capaian Kepatuhan Upaya Pencegahan Risiko Pasien Jatuh

Problem	Capaian kepatuhan upaya pencegahan risiko pasien jatuh pada periode akhir pengukuran triwulan I sebesar 95.60%. Meskipun angka ini cukup tinggi, namun masih di bawah standar 100%. Terdapat gap sebesar 4.40% yang berisiko pada keselamatan pasien. Capaian belum mencapai standart 100% karena kepatuhan petugas dalam melaksanakan upaya pencegahan risiko jatuh belum optimal, edukasi pasien dan keluarga belum optimal, monitoring dan dokukemntasi belum lengkap.
Plan	Meningkatkan capaian kepatuhan upaya pencegahan risiko pasien jatuh agar memenuhi standar 100% dengan sosialisasi ulang SOP pencegahan risiko jatuh dan audit kepatuhan pencegahan risiko jatuh secara rutin.
Do	- Melaksanakan pengkajian risiko jatuh pada pasien saat masuk dan berkala - Pemberian tanda risiko jatuh (gelang/label/stiker) - Penerapan intervensi pencegahan sesuai tingkat risiko - Edukasi pasien dan keluarga tentang pencegahan jatuh
Study	Capaian indikator kepatuhan upaya pencegahan risiko jatuh pada bulan Maret sebesar 95.60%. Capaian belum mencapai standart 100% karena kepatuhan petugas dalam melaksanakan upaya pencegahan risiko jatuh belum optimal, edukasi pasien dan keluarga belum optimal, monitoring dan dokukemntasi belum lengkap. Rencana perbaikan yang akan dilakukan adalah sosialisasi ulang SOP

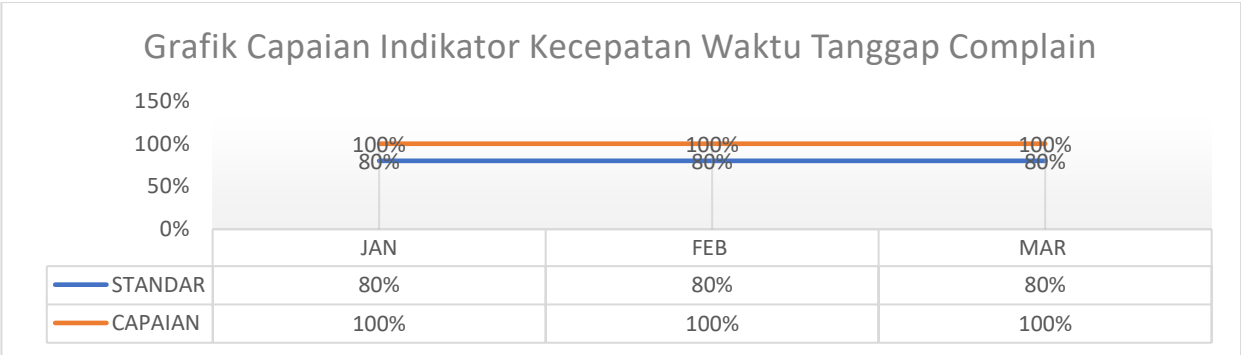
	pencegahan risiko jatuh dan audit kepatuhan pencegahan risiko jatuh secara rutin.
Action	Sosialisasi ulang SOP pencegahan risiko jatuh dan angka kepatuhan upaya pencegahan risiko pasien jatuh

Tabel 3.12 Rencana Tindak Lanjut

No	Rencana Kegiatan	Tujuan	Sasaran	Strategik	Pelaksana	Waktu
1	Sosialisasi ulang SOP pencegahan risiko jatuh	Meningkatkan pemahaman staf tentang kepatuhan upaya pencegahan resiko jatuh	Seluruh tenaga kesehatan	Sosialisasi ulang standar pencegahan risiko jatuh	Komite Keperawatan	1 bulan
2	Audit kepatuhan upaya pencegahan risiko pasien jatuh	Meningkatkan kedisiplinan staf dalam pencegahan risiko pasien jatuh	Perawat dan tenaga kesehatan	Supervisi langsung di ruangan dan penguatan budaya keselamatan kerja	Kepala Ruangan	1-2 bulan

12. Kecepatan waktu tanggap complain

Gambar 12. Grafik Capaian Indikator Kecepatan Waktu Tanggap Complain



Analisis:

Pada Triwulan I tahun 2026, capaian indikator kecepatan waktu tanggap komplain di RS Prima Husada Malang mencapai **100%** dan telah memenuhi standar yang ditetapkan yaitu **100%**. Capaian ini berhasil dipertahankan secara konsisten selama **tiga bulan berturut-turut**, yang menunjukkan efektivitas sistem pengelolaan komplain yang telah diterapkan oleh rumah sakit.

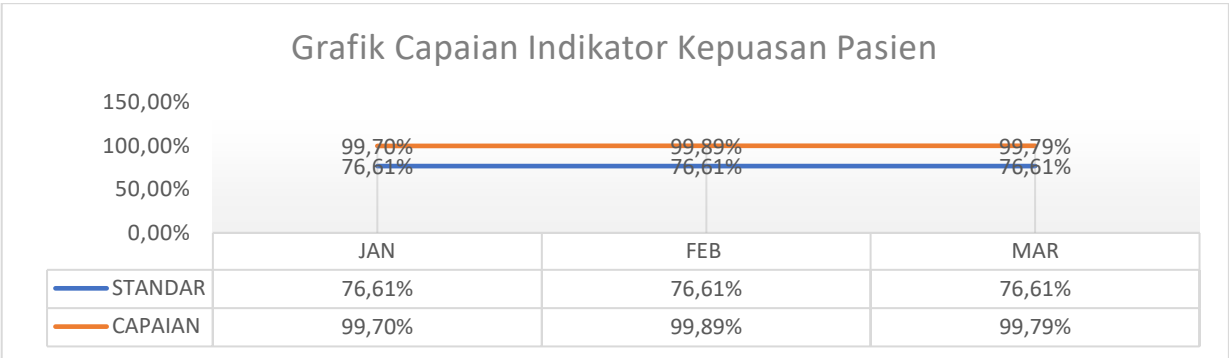
Keberhasilan pencapaian indikator ini tidak terlepas dari kerja sama yang baik antara Petugas Pemberi Informasi dan Penanganan Pengaduan (PIPP) dengan manajemen rumah sakit dalam memastikan setiap komplain yang diterima segera ditindaklanjuti sesuai prosedur. Selain itu, rumah sakit telah menyediakan berbagai mekanisme pelaporan yang mudah diakses oleh pasien dan keluarga, seperti melalui PIPP, telepon, WhatsApp, dan formulir pengaduan online, sehingga proses penerimaan dan penanganan komplain dapat dilakukan dengan cepat dan efektif.

Faktor lain yang turut mendukung capaian ini adalah tersedianya petugas yang telah mendapatkan pelatihan manajemen komplain dan memiliki kemampuan komunikasi yang baik dalam menangani keluhan pasien maupun keluarga. Untuk mempertahankan capaian tersebut,

perlu dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala, peningkatan kompetensi petugas, serta penguatan budaya pelayanan yang responsif terhadap kebutuhan dan keluhan pelanggan. Dengan upaya yang berkesinambungan, diharapkan capaian indikator kecepatan waktu tanggap komplain dapat terus dipertahankan pada triwulan berikutnya sehingga mendukung peningkatan mutu pelayanan dan kepuasan pasien.

13. Kepuasan Pasien

Gambar 13. Grafik Capaian Indikator Kepuasan Pasien



Analisis:

Pada Triwulan I tahun 2026, capaian indikator kepuasan pasien di RS Prima Husada Malang mencapai **99,79%** pada akhir periode pengukuran. Berdasarkan hasil monitoring selama Januari hingga Maret, capaian indikator ini mengalami sedikit penurunan sebesar **0,10%** dibandingkan bulan sebelumnya. Meskipun demikian, capaian tersebut masih berada jauh di atas standar yang ditetapkan yaitu **76,61%**, sehingga menunjukkan tingkat kepuasan pasien yang sangat baik terhadap pelayanan yang diberikan rumah sakit.

Tingginya tingkat kepuasan pasien mencerminkan bahwa pelayanan yang diberikan telah memenuhi harapan dan kebutuhan pasien pada berbagai aspek pelayanan, baik dari segi mutu pelayanan, komunikasi petugas, fasilitas, maupun proses pelayanan yang diterima. Penurunan yang terjadi relatif kecil dan tidak memengaruhi pencapaian standar, namun tetap perlu menjadi perhatian agar tidak berlanjut pada periode berikutnya.

Untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian yang telah diperoleh, rumah sakit perlu terus melakukan monitoring terhadap hasil survei kepuasan pasien, menindaklanjuti masukan dan keluhan yang disampaikan, serta melakukan perbaikan berkelanjutan pada aspek pelayanan yang masih memerlukan peningkatan. Dengan upaya tersebut, diharapkan tingkat kepuasan pasien dapat tetap terjaga dan terus meningkat pada triwulan berikutnya.

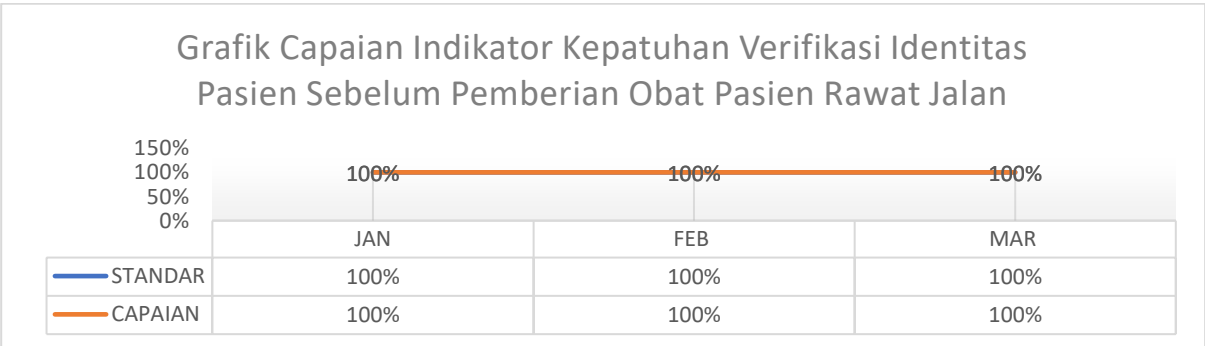
3.2 Pemantauan Indikator Sasaran Keselamatan Pasien

Tabel 3. Capaian Indikator Sasaran Keselamatan Pasien

No.	Judul Indikator	Bulan			Standar	Rata-Rata	Keterangan
		Jan	Feb	Mar			
1.	Kepatuhan verifikasi identitas pasien sebelum pemberian obat pasien rawat jalan (farmasi)	100%	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan
2.	Kepatuhan pelaporan hasil kritis radiologi (radiologi)	100%	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan
3.	Kepatuhan penempelan label obat LASA dan obat obatan High Alert dirawat inap	-	92.14%	92.90%	100%	92.52%	PDSA
4.	Kepatuhan penandaan lokasi operasi (IKO)	100%	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan
5.	Kepatuhan Petugas Kesehatan Melakukan 6 langkah cuci tangan (PPI)	85.05%	85.70%	85.91%	100%	85.55%	PDSA
6.	Kepatuhan pemasangan handrail dan penguncian roda brankar (IGD, IRNA, IKO)	-	87.11%	92.08%	100%	89.60%	PDSA

3.1.2 Analisis Capaian Indikator Sasaran Keselamatan Pasien

3. Kepatuhan veridikasi identitas pasien sebelum pemberian obat pasien rawat jalan



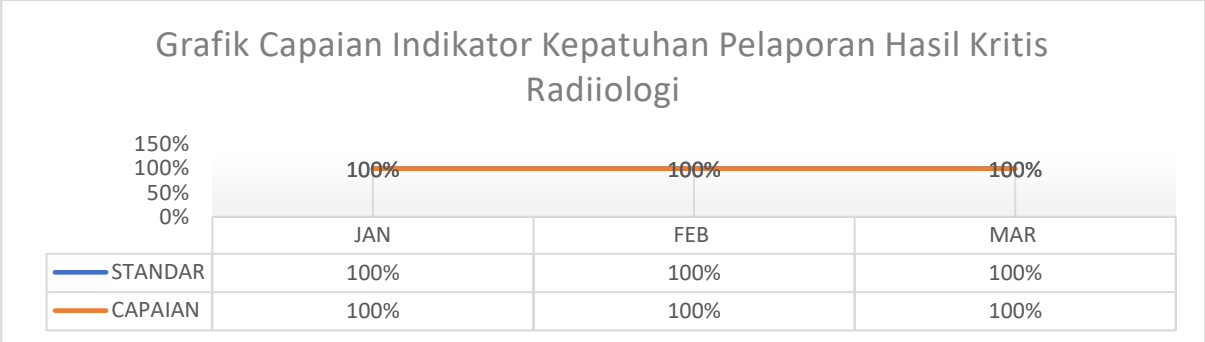
Analisis:

Pada Triwulan I tahun 2026, indikator kepatuhan verifikasi identitas pasien sebelum pemberian obat pada pasien rawat jalan perlu terus dimonitor untuk memastikan seluruh petugas melaksanakan proses identifikasi sesuai standar yang telah ditetapkan. Verifikasi identitas pasien sebelum pemberian obat merupakan salah satu langkah penting dalam menjamin keselamatan pasien dan mencegah terjadinya kesalahan pemberian obat.

Capaian indikator yang tinggi menunjukkan bahwa petugas telah menerapkan proses verifikasi identitas dengan baik sebelum menyerahkan obat kepada pasien. Namun, apabila masih ditemukan ketidakpatuhan, sekecil apa pun, hal tersebut tetap perlu menjadi perhatian karena berpotensi menimbulkan *medication error*. Oleh karena itu, diperlukan upaya berkelanjutan melalui sosialisasi dan edukasi kepada petugas, penguatan budaya keselamatan pasien, monitoring dan audit kepatuhan secara berkala, serta pemberian umpan balik terhadap hasil pengukuran indikator.

Dengan pelaksanaan upaya perbaikan yang konsisten, diharapkan kepatuhan verifikasi identitas pasien sebelum pemberian obat dapat dipertahankan atau ditingkatkan sehingga keselamatan pasien dan mutu pelayanan farmasi rawat jalan tetap terjaga.

4. Kepatuhan pelaporan hasil kritis radiologi



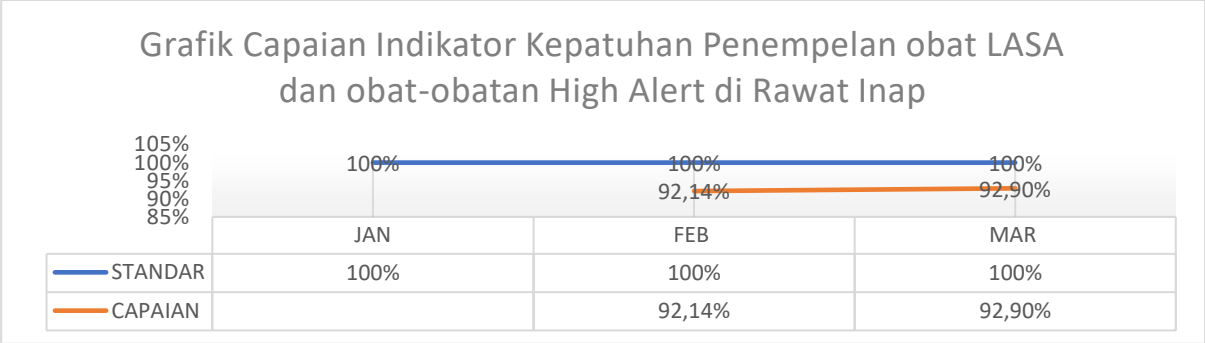
Analisis:

Pada Triwulan I tahun 2026, indikator kepatuhan pelaporan hasil kritis radiologi perlu terus dipantau untuk memastikan seluruh hasil pemeriksaan yang termasuk kategori kritis dapat dilaporkan kepada dokter penanggung jawab pasien secara tepat waktu sesuai dengan kebijakan rumah sakit. Pelaporan hasil kritis radiologi merupakan bagian penting dalam menjaga keselamatan pasien karena hasil tersebut sering kali memerlukan tindak lanjut medis segera.

Capaian indikator yang memenuhi standar menunjukkan bahwa proses identifikasi, komunikasi, dan dokumentasi hasil kritis radiologi telah berjalan dengan baik. Keberhasilan ini mencerminkan adanya koordinasi yang efektif antara petugas radiologi dan tenaga medis dalam menyampaikan informasi penting yang berhubungan dengan kondisi pasien.

Untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian indikator, perlu dilakukan sosialisasi secara berkala mengenai kebijakan dan SPO pelaporan hasil kritis radiologi, penguatan alur komunikasi antarunit, monitoring kepatuhan pelaporan, serta evaluasi terhadap setiap kendala yang ditemukan dalam proses pelaporan. Dengan pelaksanaan upaya tersebut secara konsisten, diharapkan kepatuhan pelaporan hasil kritis radiologi dapat terus dipertahankan sehingga mendukung peningkatan mutu pelayanan dan keselamatan pasien.

5. Kepatuhan penempelan label obat LASA dan obat-obatan High Alert di Rawat Inap



Analisis:

Pada Triwulan I tahun 2026, indikator kepatuhan penempelan label obat **LASA (Look Alike Sound Alike)** dan obat-obatan **High Alert** di rawat inap menunjukkan capaian yang baik. Pengukuran indikator belum dilakukan pada bulan Januari, sehingga analisis triwulan didasarkan pada hasil pengukuran bulan Februari dan Maret. Pada bulan Februari capaian sebesar **92,14%**, kemudian meningkat menjadi **92,90%** pada bulan Maret atau mengalami peningkatan sebesar **0,76%**.

Masih terdapat gap sebesar **7,10%** untuk mencapai standar 100%. Oleh karena itu, diperlukan upaya berkelanjutan melalui monitoring dan supervisi rutin, sosialisasi kepada petugas terkait pentingnya pelabelan obat LASA dan High Alert, serta evaluasi berkala terhadap kelengkapan label di setiap unit rawat inap. Dengan upaya tersebut, diharapkan capaian indikator dapat terus meningkat dan mencapai hasil yang lebih optimal pada triwulan berikutnya.

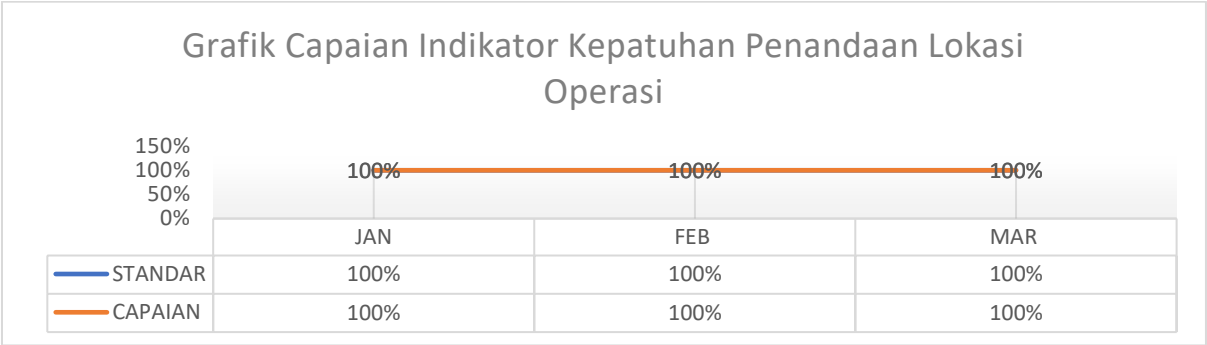
Tabel 3.12 PDSA Capaian Kepatuhan penempelan label obat LASA dan obat-obatan High Alert di Rawat Inap

Problem	Pada Triwulan I tahun 2026, indikator kepatuhan penempelan label obat LASA (Look Alike Sound Alike) dan obat-obatan High Alert di rawat inap menunjukkan capaian yang baik. Pengukuran indikator belum dilakukan pada bulan Januari, sehingga analisis triwulan didasarkan pada hasil pengukuran bulan Februari dan Maret. Pada bulan Februari capaian sebesar 92,14% , kemudian meningkat menjadi 92,90% pada bulan Maret atau mengalami peningkatan sebesar 0,76% .
Plan	Meningkatkan capaian kepatuhan penempelan label obat LASA dan obat-obatan High Alert di Rawat Inap agar mencapai 100% dengan monitoring dan supervise rutin.
Do	Melakukan inspeksi berkala terhadap pelabelan obat LASA dan High Alert di seluruh unit rawat inap, memberikan edukasi kepada petugas terkait pentingnya pelabelan obat berisiko tinggi, serta memastikan ketersediaan label di setiap unit.
Study	Melakukan evaluasi hasil monitoring kepatuhan pelabelan obat setiap bulan, mengidentifikasi unit yang belum patuh, serta menganalisis penyebab ketidaklengkapan pelabelan.
Action	Menindaklanjuti hasil evaluasi dengan memberikan umpan balik kepada unit terkait, melakukan pembinaan kepada petugas yang belum patuh, serta menetapkan monitoring rutin sebagai kegiatan berkelanjutan untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian indikator.

Tabel 3.13 Rencana Tindak Lanjut

No	Rencana Kegiatan	Tujuan	Sasaran	Strategik	Pelaksana	Waktu
1	Monitoring kepatuhan penempelan label obat LASA dan High Alert	Meningkatkan kepatuhan pelabelan obat	Seluruh unit rawat inap	Melakukan audit dan supervisi rutin	Instalasi Farmasi, Kepala Ruangan	1-3 bulan
2	Sosialisasi dan edukasi pelabelan obat LASA dan High Alert	Meningkatkan pemahaman petugas	Perawat dan petugas farmasi	Edukasi, briefing, dan refreshment	Instalasi Farmasi, Komite Mutu	1-3 bulan
3	Evaluasi dan umpan balik hasil monitoring	Mengetahui kendala dan meningkatkan kepatuhan	Unit dengan capaian belum optimal	Penyampaian hasil evaluasi dan tindak lanjut perbaikan	Instalasi Farmasi, Kepala Ruangan	1-3 bulan

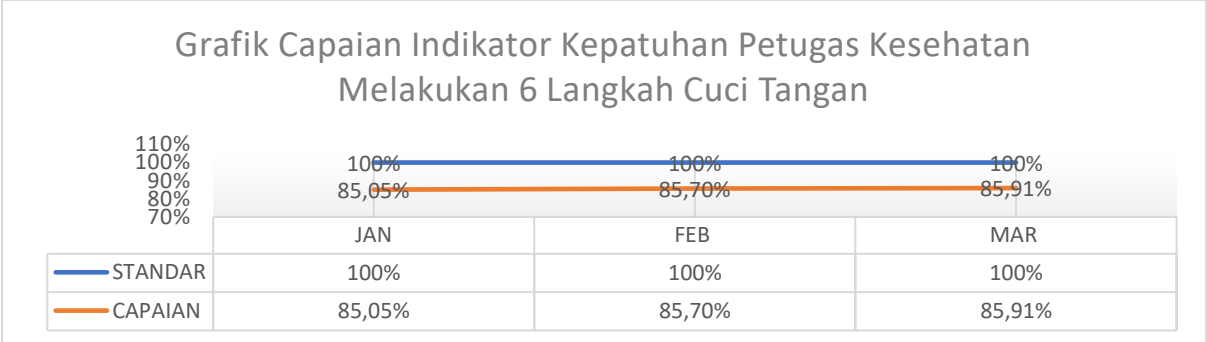
6. Kepatuhan penandaan lokasi operasi



Analisis:

Pada Triwulan I tahun 2026, indikator kepatuhan penandaan lokasi operasi merupakan salah satu upaya penting dalam penerapan keselamatan pasien untuk mencegah terjadinya kesalahan lokasi, prosedur, maupun pasien saat tindakan pembedahan. Penandaan lokasi operasi yang dilakukan sesuai prosedur memastikan bahwa tindakan operasi dilakukan pada lokasi yang benar dan telah dikonfirmasi bersama pasien serta tim bedah. Capaian indikator yang memenuhi standar menunjukkan bahwa proses penandaan lokasi operasi telah dilaksanakan secara konsisten oleh tenaga kesehatan yang berwenang sebelum tindakan operasi dilakukan. Hal ini mencerminkan kepatuhan terhadap kebijakan rumah sakit dan implementasi prinsip keselamatan pasien dalam pelayanan bedah. Untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian indikator, perlu dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan penandaan lokasi operasi, sosialisasi dan penguatan kepatuhan terhadap SPO yang berlaku, serta pelaksanaan *surgical safety checklist* secara konsisten. Selain itu, koordinasi yang baik antara dokter operator, perawat, dan tim kamar operasi perlu terus dipertahankan guna memastikan seluruh tahapan keselamatan pasien pada pelayanan bedah dapat terlaksana dengan optimal.

7. Kepatuhan petugas kesehatan melakukan 6 langkah cuci tangan



Analisis:

Pada Triwulan I tahun 2026, indikator kepatuhan petugas kesehatan dalam melakukan 6 langkah cuci tangan menunjukkan capaian yang baik meningkat dari **85,05%** pada bulan Januari menjadi **85,70%** pada bulan Februari dan **85,91%** pada bulan Maret. Secara keseluruhan terdapat peningkatan sebesar **0,86%** selama periode triwulan. Capaian ini masih belum mencapai standar 100%, sehingga masih diperlukan upaya peningkatan kepatuhan. Beberapa kegiatan yang dapat dilakukan antara lain edukasi dan refreshment mengenai teknik 6 langkah cuci tangan yang benar, observasi dan monitoring kepatuhan secara rutin, pemberian umpan balik kepada unit pelayanan, serta penguatan budaya keselamatan pasien dan pencegahan infeksi. Dengan upaya yang berkelanjutan, diharapkan kepatuhan petugas kesehatan dalam melakukan 6 langkah cuci tangan dapat terus meningkat pada triwulan berikutnya.

Tabel 3.14 PDSA Capaian Kepatuhan petugas kesehatan melakukan 6 langkah cuci tangan

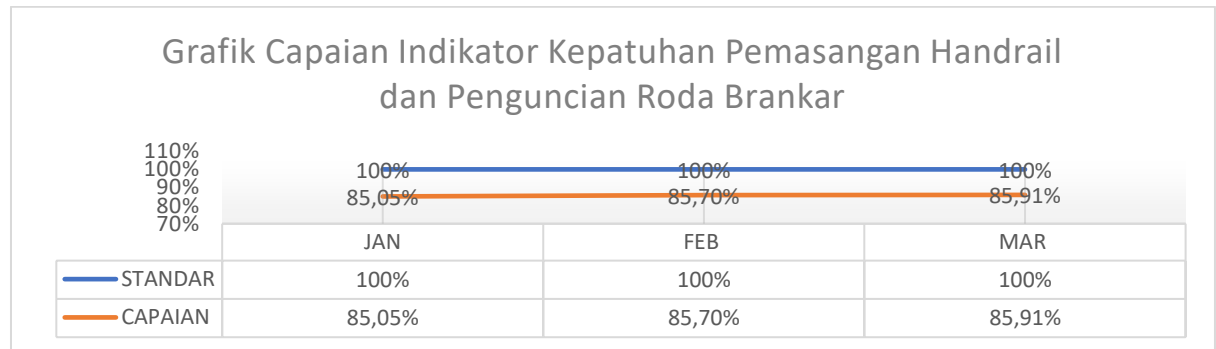
Problem	Pada Triwulan I tahun 2026, indikator kepatuhan petugas kesehatan dalam melakukan 6 langkah cuci tangan menunjukkan capaian yang baik meningkat dari 85,05% pada bulan Januari menjadi 85,70% pada bulan Februari dan 85,91% pada bulan Maret. Secara keseluruhan terdapat peningkatan sebesar 0,86%
---------	--

	selama periode triwulan. Capaian ini masih belum mencapai standar 100%, sehingga masih diperlukan upaya peningkatan kepatuhan.
Plan	Meningkatkan kepatuhan petugas kesehatan dalam melakukan 6 langkah cuci tangan melalui edukasi, monitoring, dan supervisi secara berkala.
Do	Melaksanakan sosialisasi dan refreshment mengenai teknik 6 langkah cuci tangan yang benar, melakukan observasi kepatuhan secara rutin, serta mengingatkan petugas untuk menerapkan prosedur cuci tangan sesuai standar.
Study	Mengevaluasi hasil observasi kepatuhan setiap bulan, mengidentifikasi unit atau petugas dengan tingkat kepatuhan yang belum optimal, serta menganalisis faktor penyebab ketidakpatuhan.
Action	Memberikan umpan balik kepada unit terkait, melakukan pembinaan dan edukasi lanjutan, serta mempertahankan kegiatan monitoring rutin untuk meningkatkan capaian kepatuhan hingga mencapai target yang ditetapkan.

Tabel 3.15 Rencana Tindak Lanjut

No	Rencana Kegiatan	Tujuan	Sasaran	Strategik	Pelaksana	Waktu
1	Sosialisasi dan refreshment 6 langkah cuci tangan	Meningkatkan pemahaman petugas tentang teknik cuci tangan yang benar	Seluruh tenaga kesehatan	Edukasi, briefing, dan simulasi	IPCN, PPI, Kepala Unit	1-3 bulan
2	Monitoring dan observasi kepatuhan cuci tangan	Mengetahui tingkat kepatuhan petugas	Seluruh tenaga kesehatan	Audit dan observasi langsung	IPCN, Tim PPI	1-3 bulan
3	Evaluasi dan umpan balik hasil monitoring	Meningkatkan kepatuhan dan memperbaiki kekurangan	Unit dengan capaian belum optimal	Penyampaian hasil monitoring dan tindak lanjut perbaikan	IPCN, Kepala Unit, Komite Mutu	1-3 bulan

8. Kepatuhan pemasangan handrail dan penguncian roda brankar



Analisis:

Pada Triwulan I tahun 2026, indikator **kepatuhan pemasangan handrail dan penguncian roda brankar** menunjukkan capaian yang belum memenuhi standar yang ditetapkan yaitu **100%**. Capaian pada bulan Januari sebesar **85,05%**, meningkat menjadi **85,70%** pada bulan Februari dan **85,91%** pada bulan Maret. Secara keseluruhan terdapat peningkatan sebesar **0,86%** selama periode triwulan. Meskipun menunjukkan tren peningkatan, capaian masih memiliki **gap sebesar 14,09%** terhadap standar. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat petugas yang belum secara

konsisten melakukan pemasangan handrail dan penguncian roda brankar sesuai prosedur saat transportasi maupun perawatan pasien. Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan risiko pasien jatuh dan cedera selama proses pelayanan.

Untuk meningkatkan capaian indikator, diperlukan upaya berkelanjutan melalui edukasi kepada petugas mengenai pentingnya keselamatan pasien saat menggunakan brankar, monitoring dan supervisi rutin, serta pemberian umpan balik kepada unit yang belum mencapai target. Dengan upaya tersebut, diharapkan kepatuhan pemasangan handrail dan penguncian roda brankar dapat terus meningkat dan mencapai standar yang ditetapkan.

Tabel 3.16 PDSA Capaian Kepatuhan pemasangan handrail dan penguncian roda brankar

Problem	Pada Triwulan I tahun 2026, indikator kepatuhan pemasangan handrail dan penguncian roda brankar menunjukkan peningkatan dari 85,05% pada bulan Januari menjadi 85,70% pada bulan Februari dan 85,91% pada bulan Maret. Namun capaian tersebut masih belum memenuhi standar 100%.
Plan	Meningkatkan kepatuhan petugas dalam pemasangan handrail dan penguncian roda brankar melalui edukasi, monitoring, dan supervisi berkala.
Do	Melakukan sosialisasi terkait keselamatan pasien selama transportasi, mengingatkan petugas untuk selalu memasang handrail dan mengunci roda brankar, serta melakukan observasi kepatuhan secara rutin.
Study	Menganalisis hasil observasi dan audit kepatuhan, mengidentifikasi unit atau petugas yang belum patuh, serta mengevaluasi faktor penyebab ketidakpatuhan.
Action	Memberikan umpan balik kepada unit terkait, melakukan pembinaan kepada petugas yang belum patuh, serta meningkatkan frekuensi monitoring untuk memastikan kepatuhan mencapai target.

Tabel 3.17 Rencana Tindak Lanjut

No	Rencana Kegiatan	Tujuan	Sasaran	Strategik	Pelaksana	Waktu
1	Sosialisasi keselamatan pasien terkait penggunaan brankar	Meningkatkan pemahaman petugas mengenai pentingnya pemasangan handrail dan penguncian roda brankar	Seluruh tenaga kesehatan dan petugas transportasi pasien	Edukasi, briefing, dan refreshment	Tim PPI, Komite Mutu, Kepala Unit	1-3 bulan
2	Monitoring dan audit kepatuhan penggunaan handrail dan penguncian roda brankar	Mengetahui tingkat kepatuhan petugas	Seluruh unit pelayanan	Observasi langsung dan audit berkala	Kepala Unit, Komite Mutu	1-3 bulan
3	Evaluasi hasil monitoring dan pemberian umpan balik	Meningkatkan kepatuhan dan memperbaiki ketidaksesuaian	Unit dengan capaian belum optimal	Penyampaian hasil evaluasi dan tindak lanjut perbaikan	Komite Mutu, Kepala Unit	1-3 bulan

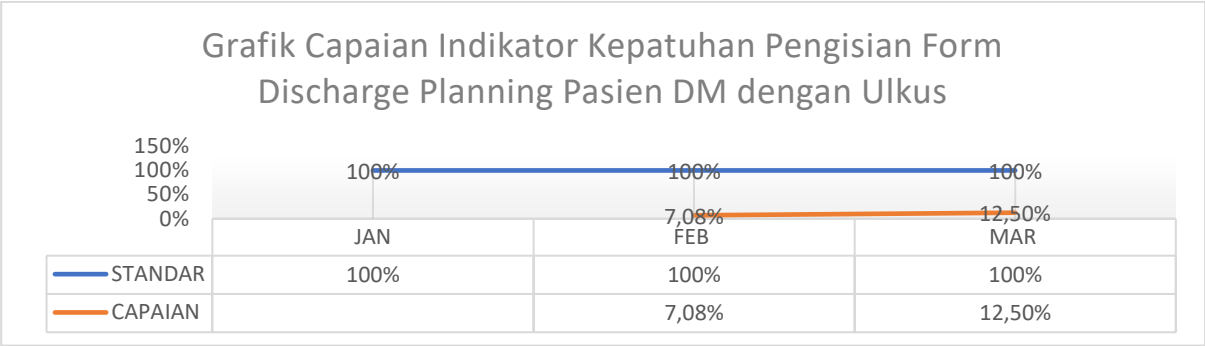
3.3 Pemantauan Indikator Mutu Pelayanan Klinis Prioritas

No.	Judul Indikator	Bulan		Rata-Rata	Keterangan
-----	-----------------	-------	--	-----------	------------

		Jan	Feb	Mar	Standar		
1.	Kepatuhan Pengisian Form Discharge Planing pasien DM dengan ulkus (Rawat Inap)		7.08%	12.50%	100%	9.79%	PDSA
2.	Kepatuhan Pengisian Form Edukasi pada pasien DM dengan ulkus (Rawat Inap)		12.1%	21.48%	100%	16.79%	PDSA
3.	Kepatuhan PPK dan CP Pasien DM (Rawat Inap)		8.31%	12.05%	100%	10.18%	PDSA

3.3.1 Analisis Pemantauan Indikator Mutu Pelayanan Klinis Prioritas

1. Kepatuhan Pengisian Form Discharge Planning Pasien DM dengan Ulkus



Analisis:

Pada Triwulan I tahun 2026, indikator kepatuhan pengisian form *discharge planning* pasien Diabetes Melitus (DM) dengan ulkus menunjukkan capaian yang masih rendah. Pengukuran belum dilakukan pada bulan Januari, sehingga analisis triwulan didasarkan pada hasil pengukuran bulan Februari dan Maret. Capaian meningkat dari **7,08%** pada bulan Februari menjadi **12,50%** pada bulan Maret atau mengalami peningkatan sebesar **5,42%**. Meskipun terdapat perbaikan, capaian tersebut masih jauh di bawah standar yang ditetapkan yaitu **100%**. Rendahnya kepatuhan pengisian form *discharge planning* menunjukkan bahwa proses perencanaan pemulangan pasien belum terdokumentasi secara optimal. Kondisi ini dapat dipengaruhi oleh kurangnya pemahaman petugas mengenai pentingnya *discharge planning*, beban kerja yang tinggi, ketidaklengkapan dokumentasi, maupun belum optimalnya monitoring terhadap pengisian formulir.

Discharge planning yang lengkap sangat penting untuk memastikan kesinambungan perawatan pasien setelah pulang, meningkatkan kepatuhan pasien terhadap terapi, serta mengurangi risiko komplikasi dan kejadian rawat ulang. Oleh karena itu, diperlukan upaya perbaikan melalui sosialisasi dan edukasi kepada tenaga kesehatan, penyederhanaan alur dokumentasi bila diperlukan, monitoring dan audit kepatuhan secara berkala, serta pemberian umpan balik kepada unit terkait. Dengan upaya tersebut, diharapkan kepatuhan pengisian form *discharge planning* pasien DM dengan ulkus dapat meningkat secara bertahap dan mendekati standar yang telah ditetapkan pada periode berikutnya.

Tabel 3.18 PDSA Capaian Kepatuhan Pengisian Form Discharge Planning Pasien DM dengan Ulkus

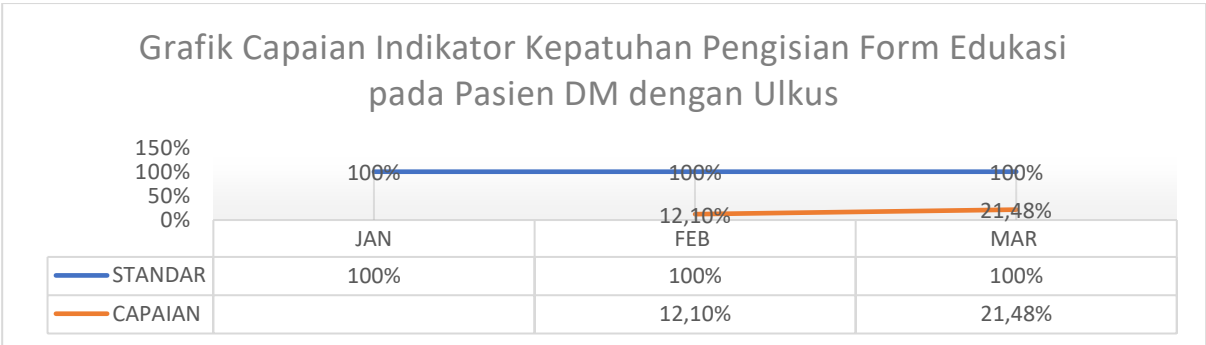
Problem	Pada Triwulan I tahun 2026, indikator kepatuhan pengisian form discharge planning pasien DM dengan ulkus menunjukkan capaian yang masih rendah. Pengukuran belum dilakukan pada bulan Januari, sehingga analisis triwulan didasarkan pada hasil pengukuran bulan Februari dan Maret. Capaian meningkat dari 7,08% pada bulan Februari menjadi 12,50% pada bulan Maret atau mengalami peningkatan sebesar 5,42%. Meskipun terdapat perbaikan, capaian tersebut masih jauh di bawah standar yang ditetapkan yaitu 100%.
Plan	Meningkatkan kepatuhan pengisian form discharge planning pasien DM dengan ulkus melalui edukasi petugas, penguatan monitoring, dan evaluasi dokumentasi secara berkala.

Do	Melakukan sosialisasi mengenai pentingnya discharge planning, memberikan pendampingan pengisian formulir kepada petugas, serta melakukan monitoring kelengkapan form pada pasien DM dengan ulkus.
Study	Mengevaluasi hasil monitoring, mengidentifikasi kendala dalam pengisian formulir, serta menganalisis penyebab rendahnya kepatuhan dokumentasi.
Action	Memberikan umpan balik kepada unit terkait, melakukan pembinaan kepada petugas yang belum patuh, serta menyusun langkah perbaikan untuk meningkatkan kepatuhan pengisian form discharge planning.

Tabel 3.19 Rencana Tindak Lanjut

No	Rencana Kegiatan	Tujuan	Sasaran	Strategik	Pelaksana	Waktu
1	Sosialisasi dan edukasi pengisian form discharge planning pasien DM dengan ulkus	Meningkatkan pemahaman petugas mengenai pentingnya discharge planning	Dokter, perawat, dan tenaga kesehatan terkait	Edukasi, briefing, dan pendampingan pengisian formulir	Kepala Ruangan, Komite Mutu, Tim Casemix Manager	1-3 bulan
2	Monitoring dan audit kepatuhan pengisian form discharge planning	Mengetahui tingkat kepatuhan dan kelengkapan dokumentasi	Seluruh unit yang merawat pasien DM dengan ulkus	Audit rekam medis dan observasi berkala	Casemix Manager, Komite Mutu	1-3 bulan
3	Evaluasi hasil monitoring dan pemberian umpan balik	Meningkatkan kepatuhan dan memperbaiki kendala pelaksanaan	Unit dengan capaian belum optimal	Analisis hasil audit, umpan balik, dan tindak lanjut perbaikan	Komite Mutu, Kepala Ruangan, Casemix Manager	1-3 bulan

2. Kepatuhan Pengisian Form Edukasi pada Pasien DM dengan Ulkus



Analisis:

Pada Triwulan I tahun 2026, indikator kepatuhan pengisian form edukasi pada pasien DM dengan ulkus menunjukkan adanya peningkatan, namun capaian masih belum optimal. Pengukuran belum dilakukan pada bulan Januari, sehingga analisis triwulan didasarkan pada hasil pengukuran bulan Februari dan Maret. Capaian meningkat dari **12,10%** pada bulan Februari menjadi **21,48%** pada bulan Maret atau mengalami peningkatan sebesar **9,38%**.

Meskipun terjadi perbaikan, capaian tersebut masih jauh di bawah standar yang ditetapkan yaitu **100%**, sehingga masih terdapat **gap sebesar 78,52%**. Hasil ini menunjukkan bahwa pelaksanaan dan dokumentasi edukasi kepada pasien DM dengan ulkus belum dilakukan secara konsisten pada seluruh pasien yang menjadi sasaran indikator. Edukasi pasien merupakan bagian penting dalam pengelolaan pasien DM dengan ulkus karena berperan dalam meningkatkan pemahaman pasien mengenai perawatan luka, kepatuhan pengobatan, pengendalian gula darah, pola makan, serta pencegahan komplikasi. Oleh karena itu, rendahnya kepatuhan pengisian form edukasi perlu menjadi perhatian untuk meningkatkan mutu pelayanan dan keselamatan pasien. Upaya perbaikan yang dapat dilakukan antara lain melalui sosialisasi kepada tenaga kesehatan mengenai pentingnya edukasi dan dokumentasinya, monitoring dan audit kepatuhan secara berkala, penyediaan form yang mudah diakses dan diisi, serta pemberian umpan balik kepada unit terkait. Dengan pelaksanaan perbaikan secara berkelanjutan, diharapkan kepatuhan pengisian form edukasi pada pasien DM dengan ulkus dapat terus meningkat dan mendekati standar yang telah ditetapkan pada periode berikutnya.

Tabel 3.20 PDSA Kepatuhan Pengisian Form Edukasi pada Pasien DM dengan Ulkus

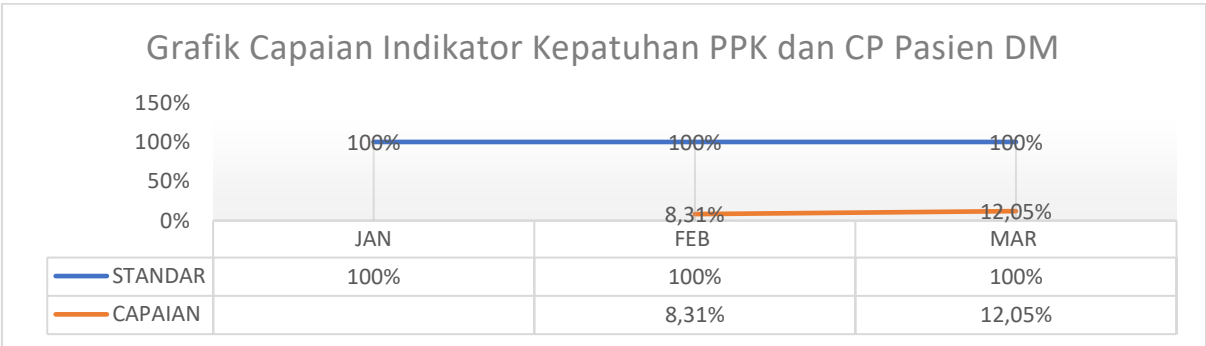
Problem	Pada Triwulan I tahun 2026, indikator kepatuhan pengisian form edukasi pada pasien DM dengan ulkus menunjukkan adanya peningkatan, namun capaian masih belum optimal. Pengukuran belum dilakukan pada bulan Januari, sehingga analisis triwulan didasarkan pada hasil pengukuran bulan Februari dan Maret. Capaian meningkat dari 12,10% pada bulan Februari menjadi 21,48% pada bulan Maret atau mengalami peningkatan sebesar 9,38%. Meskipun terjadi perbaikan, capaian tersebut masih jauh di bawah standar yang ditetapkan yaitu 100%, sehingga masih terdapat gap sebesar 78,52%.
Plan	Meningkatkan kepatuhan pengisian form edukasi pada pasien DM dengan ulkus melalui penguatan edukasi kepada petugas, monitoring dokumentasi, dan evaluasi berkala.
Do	Melaksanakan sosialisasi mengenai pentingnya edukasi pasien dan dokumentasinya, melakukan pendampingan pengisian form edukasi, serta mengingatkan petugas untuk melengkapi dokumentasi setiap kali edukasi diberikan kepada pasien.
Study	Melakukan audit dan evaluasi terhadap kelengkapan form edukasi, mengidentifikasi kendala dalam pelaksanaan dan dokumentasi edukasi, serta menganalisis penyebab rendahnya kepatuhan.
Action	Memberikan umpan balik kepada unit terkait, melakukan pembinaan kepada petugas yang belum patuh, serta menetapkan monitoring rutin untuk meningkatkan kepatuhan pengisian form edukasi.

Tabel 3.21 Rencana Tindak Lanjut

No	Rencana Kegiatan	Tujuan	Sasaran	Strategik	Pelaksana	Waktu
1	Sosialisasi dan refreshment pengisian form edukasi pasien DM dengan ulkus	Meningkatkan pemahaman petugas mengenai pentingnya edukasi dan dokumentasinya	Dokter, perawat, dan tenaga kesehatan terkait	Edukasi, briefing, dan pendampingan	Kepala Ruangan, Komite Mutu, Tim Edukasi Pasien	1-3 bulan
2	Monitoring dan audit kepatuhan pengisian	Mengetahui tingkat kepatuhan dan kelengkapan	Seluruh unit yang merawat pasien DM	Audit rekam medis dan observasi berkala	Komite Mutu, Kepala Ruangan	1-3 bulan

	form edukasi	dokumentasi edukasi	dengan ulkus			
3	Evaluasi hasil monitoring dan pemberian umpan balik	Meningkatkan kepatuhan dan memperbaiki kendala pelaksanaan	Unit dengan capaian belum optimal	Analisis hasil audit, umpan balik, dan tindak lanjut perbaikan	Komite Mutu, Kepala Ruangan, Tim Edukasi Pasien	1-3 bulan

3. Kepatuhan PPK dan CP Pasien DM



Analisis:

Pada Triwulan I tahun 2026, indikator kepatuhan terhadap **Panduan Praktik Klinis (PPK) dan Clinical Pathway (CP) pasien Diabetes Melitus (DM)** menunjukkan capaian yang masih rendah meskipun terdapat peningkatan dari bulan sebelumnya. Pengukuran indikator belum dilakukan pada bulan Januari, sehingga analisis triwulan didasarkan pada hasil pengukuran bulan Februari dan Maret. Capaian meningkat dari **8,31%** pada bulan Februari menjadi **12,05%** pada bulan Maret atau mengalami peningkatan sebesar **3,74%**. Meskipun mengalami peningkatan, capaian tersebut masih jauh di bawah standar yang ditetapkan yaitu **100%**, sehingga masih terdapat **gap sebesar 87,95%**. Hasil ini menunjukkan bahwa implementasi dan dokumentasi PPK serta CP pada pasien DM belum dilaksanakan secara optimal dan konsisten pada seluruh kasus yang menjadi sasaran indikator. Rendahnya capaian dapat disebabkan oleh kurangnya pemahaman tenaga kesehatan terhadap penggunaan PPK dan CP, ketidaklengkapan dokumentasi, keterbatasan waktu pelayanan, serta belum optimalnya monitoring dan evaluasi pelaksanaan di unit pelayanan. Padahal, penerapan PPK dan CP sangat penting untuk memastikan pelayanan pasien DM diberikan secara terstandar, efektif, efisien, dan sesuai dengan praktik berbasis bukti. Untuk meningkatkan capaian indikator, perlu dilakukan sosialisasi dan edukasi secara berkelanjutan mengenai implementasi PPK dan CP, penguatan monitoring dan audit kepatuhan, pemberian umpan balik kepada unit terkait, serta evaluasi terhadap kendala yang dihadapi dalam penerapannya. Dengan upaya perbaikan yang konsisten, diharapkan kepatuhan terhadap PPK dan CP pasien DM dapat meningkat secara bertahap sehingga kesenjangan terhadap standar semakin berkurang pada periode berikutnya.

Tabel 3.22 PDSA Capaian Kepatuhan PPK dan CP Pasien DM

Problem	Pada Triwulan I tahun 2026, indikator kepatuhan terhadap Panduan Praktik Klinis (PPK) dan Clinical Pathway (CP) pasien Diabetes Melitus (DM) menunjukkan capaian yang masih rendah meskipun terdapat peningkatan dari bulan sebelumnya. Pengukuran indikator belum dilakukan pada bulan Januari, sehingga analisis triwulan didasarkan pada hasil pengukuran bulan Februari dan Maret. Capaian meningkat dari 8,31% pada bulan Februari menjadi 12,05% pada bulan Maret atau mengalami peningkatan sebesar 3,74%. Meskipun mengalami peningkatan, capaian tersebut masih jauh di bawah standar yang ditetapkan yaitu 100%, sehingga masih terdapat gap sebesar 87,95%.
Plan	Meningkatkan kepatuhan tenaga kesehatan dalam penerapan dan dokumentasi PPK serta Clinical Pathway pasien DM melalui sosialisasi, monitoring, dan evaluasi berkala.

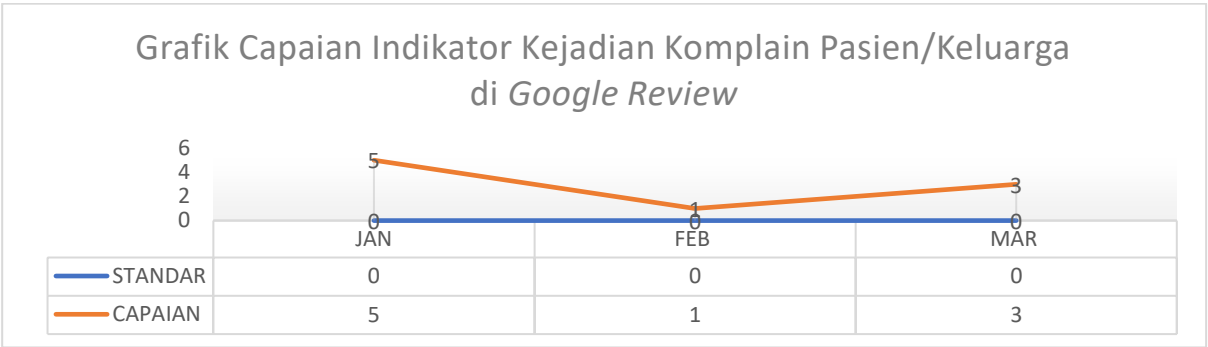
Do	Melaksanakan sosialisasi dan pelatihan terkait implementasi PPK dan CP pasien DM, melakukan pendampingan pengisian CP, serta melakukan monitoring terhadap kepatuhan pelaksanaan dan dokumentasi di unit pelayanan.
Study	Mengevaluasi hasil monitoring, mengidentifikasi kendala penerapan PPK dan CP, serta menganalisis faktor penyebab rendahnya kepatuhan pada masing-masing unit.
Action	Memberikan umpan balik kepada unit terkait, melakukan pembinaan kepada petugas yang belum patuh, serta menyusun langkah perbaikan untuk meningkatkan kepatuhan terhadap PPK dan CP pasien DM.

Tabel 3.23 Rencana Tindak Lanjut

No	Rencana Kegiatan	Tujuan	Sasaran	Strategik	Pelaksana	Waktu
1	Sosialisasi dan refreshment PPK serta Clinical Pathway pasien DM	Meningkatkan pemahaman petugas mengenai penerapan PPK dan CP	Dokter, perawat, dan tenaga kesehatan terkait	Edukasi, pelatihan, dan diskusi kasus	Komite Medik, Komite Mutu, Kepala Unit	1-3 bulan
2	Monitoring dan audit kepatuhan pelaksanaan PPK dan CP	Mengetahui tingkat kepatuhan penerapan dan dokumentasi PPK/CP	Unit yang menangani pasien DM	Audit rekam medis dan evaluasi CP	Komite Mutu, Casemix Manager, Kepala Unit	1-3 bulan
3	Evaluasi hasil audit dan pemberian umpan balik	Meningkatkan kepatuhan dan mengurangi kesenjangan terhadap standar	Unit dengan capaian belum optimal	Analisis hasil audit, umpan balik, dan tindak lanjut perbaikan	Komite Mutu, Komite Medik, Kepala Unit	1-3 bulan

3.4 Tujuan Strategis

NO	Judul Indikator	Bulan			Standar	Rata-Rata	Keterangan
		Jan '26	Feb '26	Mar '26			
1.	Kejadian complain pasien / keluarga di <i>google review</i>	5	1	3	0	3	PDSA



Analisis:

Pada Triwulan I tahun 2026, indikator kejadian komplain pasien/keluarga yang disampaikan melalui **Google Review** menunjukkan adanya fluktuasi jumlah komplain. Pada bulan Januari tercatat **5 komplain**, kemudian menurun menjadi **1 komplain** pada bulan Februari, namun kembali meningkat menjadi **3 komplain** pada bulan Maret. Capaian ini belum memenuhi standar yang ditetapkan rumah sakit yaitu **0 komplain**.

Munculnya komplain melalui Google Review menunjukkan masih terdapat aspek pelayanan yang belum sepenuhnya memenuhi harapan pasien dan keluarga. Di sisi lain, keberadaan komplain juga dapat menjadi sumber informasi yang berharga bagi rumah sakit untuk mengidentifikasi area pelayanan yang memerlukan perbaikan. Penurunan jumlah komplain pada bulan Februari menunjukkan adanya perbaikan, namun peningkatan kembali pada bulan Maret mengindikasikan bahwa upaya perbaikan yang dilakukan belum berjalan secara konsisten.

Untuk mengurangi jumlah komplain pada periode berikutnya, perlu dilakukan analisis terhadap isi dan akar penyebab setiap komplain yang masuk, tindak lanjut yang cepat dan tepat terhadap keluhan pasien, serta penguatan budaya pelayanan prima di seluruh unit. Selain itu, monitoring rutin terhadap ulasan Google Review, peningkatan komunikasi efektif petugas dengan pasien dan keluarga, serta evaluasi kepuasan pasien secara berkala perlu terus dilakukan. Dengan upaya tersebut, diharapkan jumlah komplain dapat terus menurun dan mendekati standar yang telah ditetapkan.

Tabel 3.24 PDSA Capaian Kejadian komplain pasien / keluarga di google review

Problem	Pada Triwulan I tahun 2026, indikator kejadian komplain pasien/keluarga yang disampaikan melalui Google Review menunjukkan adanya fluktuasi jumlah komplain. Pada bulan Januari tercatat 5 komplain, kemudian menurun menjadi 1 komplain pada bulan Februari, namun kembali meningkat menjadi 3 komplain pada bulan Maret. Capaian ini belum memenuhi standar yang ditetapkan rumah sakit yaitu 0 komplain.
Plan	Menurunkan jumlah komplain pasien/keluarga melalui peningkatan kualitas pelayanan, percepatan tindak lanjut keluhan, dan penguatan komunikasi antara petugas dengan pasien serta keluarga.
Do	Melakukan monitoring rutin terhadap Google Review, menindaklanjuti setiap komplain yang masuk, memberikan edukasi kepada petugas mengenai pelayanan prima dan komunikasi efektif, serta melakukan koordinasi dengan unit terkait untuk penyelesaian masalah yang dikeluhkan.
Study	Menganalisis jenis dan akar penyebab komplain yang diterima, mengevaluasi efektivitas tindak lanjut yang telah dilakukan, serta mengidentifikasi unit atau proses pelayanan yang paling sering menjadi sumber keluhan.
Action	Menyusun dan melaksanakan perbaikan berdasarkan hasil evaluasi, memberikan umpan balik kepada unit terkait, meningkatkan pengawasan terhadap area yang sering dikeluhkan, serta melakukan monitoring berkelanjutan untuk mencegah terulangnya komplain serupa.

Tabel 3.25 Rencana Tindak Lanjut

No	Rencana Kegiatan	Tujuan	Sasaran	Strategik	Pelaksana	Waktu
----	------------------	--------	---------	-----------	-----------	-------

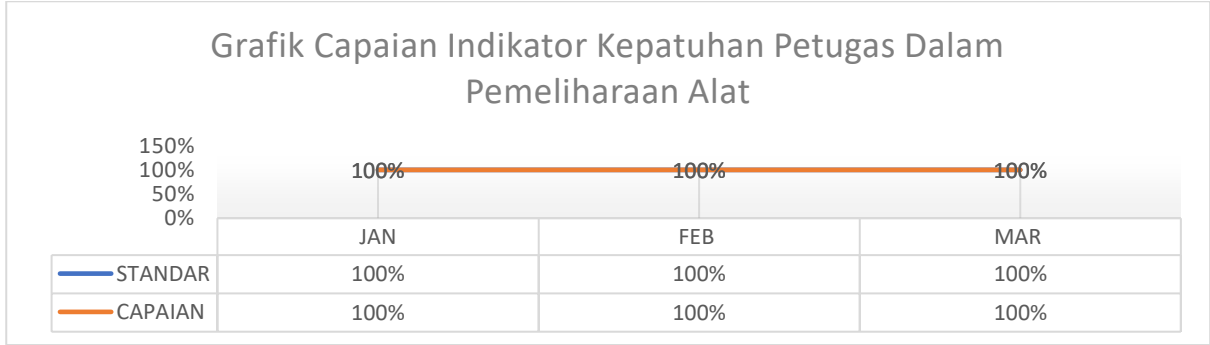
1	Monitoring dan tindak lanjut komplain Google Review	Memastikan setiap komplain ditangani secara cepat dan tepat	Seluruh komplain pasien/keluarga	Monitoring harian dan respons cepat terhadap keluhan	PIPP, Humas, Unit Terkait	1-3 bulan
2	Sosialisasi pelayanan prima dan komunikasi efektif	Meningkatkan kualitas interaksi petugas dengan pasien dan keluarga	Seluruh petugas pelayanan	Edukasi, briefing, dan pembinaan berkala	Bagian Diklat, Kepala Unit	1-3 bulan
3	Analisis tren komplain dan evaluasi perbaikan pelayanan	Mengurangi kejadian komplain berulang	Unit dengan komplain terbanyak	Analisis akar masalah, evaluasi, dan tindak lanjut perbaikan	Komite Mutu, PIPP, Manajemen	1-3 bulan

3.5 Manajemen Risiko

No	Judul Indikator	Bulan			Standar	Rata-Rata	Keterangan
		Jan '26	Feb '26	Mar '26			
1.	Kepatuhan petugas dalam pemeliharaan alat	100%	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan

3.5.1 Analisis Capaian Indikator Manajemen Risiko

3.5.1.1.1.1 Kepatuhan Petugas dalam Pemeliharaan Alat



Analisis:

Pada Triwulan I tahun 2026, indikator kepatuhan petugas dalam pemeliharaan alat mencapai **100%** dan telah memenuhi standar yang ditetapkan yaitu **100%**. Capaian ini menunjukkan bahwa seluruh kegiatan pemeliharaan alat telah dilaksanakan sesuai jadwal dan prosedur yang berlaku, sehingga mendukung kesiapan alat dalam menunjang pelayanan kepada pasien. Keberhasilan pencapaian indikator ini mencerminkan komitmen petugas dan unit terkait dalam menjaga kondisi alat kesehatan agar tetap berfungsi dengan baik, aman digunakan, serta meminimalkan risiko gangguan pelayanan akibat kerusakan alat. Selain itu, pelaksanaan pemeliharaan yang konsisten juga berperan dalam memperpanjang usia pakai alat dan menjaga akurasi hasil pemeriksaan maupun tindakan medis. Untuk mempertahankan capaian tersebut, perlu dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan pemeliharaan alat, memastikan kepatuhan terhadap jadwal pemeliharaan preventif, serta menjaga koordinasi yang baik antara pengguna alat dan unit pemeliharaan. Dengan upaya yang berkelanjutan, diharapkan indikator kepatuhan petugas

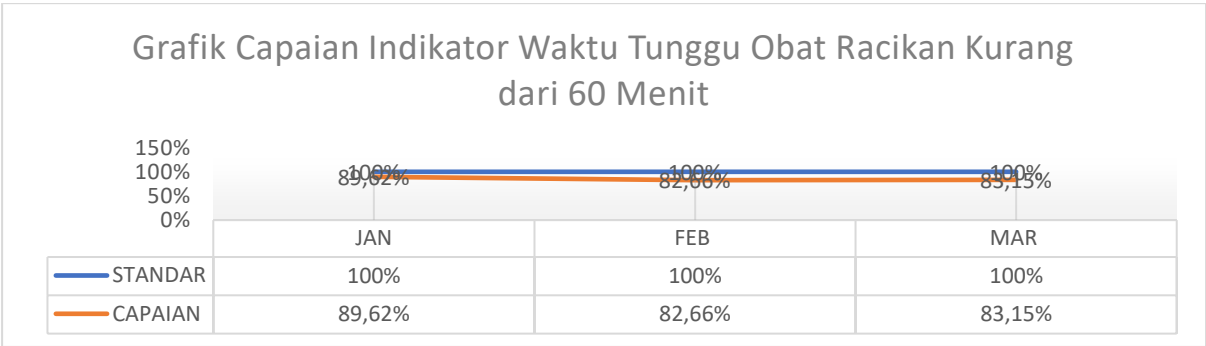
dalam pemeliharaan alat dapat terus dipertahankan sehingga mendukung mutu pelayanan dan keselamatan pasien di rumah sakit.

3.6 Perbaikan Sistem

No	Judul Indikator	Bulan			Standar	Rata-Rata	Keterangan
		Jan '26	Feb '26	Mar '26			
1.	Waktu tunggu obat racikan kurang dari 60 menit	89,62%	82,66%	83,15%	100%	85,14%	PDSA

3.6.1 Analisis Capaian Indikator Perbaikan Sistem

1. Waktu Tunggu Obat Racikan Kurang Dari 60 Menit



Analisis:

Pada Triwulan I tahun 2026, indikator **waktu tunggu obat racikan kurang dari 60 menit** menunjukkan capaian yang belum memenuhi standar yang ditetapkan yaitu **100%**. Capaian pada bulan Januari sebesar **89,62%**, mengalami penurunan menjadi **82,66%** pada bulan Februari, kemudian meningkat sedikit menjadi **83,15%** pada bulan Maret. Rata-rata capaian triwulan sebesar **85,14%**, sehingga masih terdapat **gap sebesar 14,86%** terhadap standar. Belum tercapainya target menunjukkan bahwa masih terdapat pasien yang menerima obat racikan dengan waktu tunggu lebih dari 60 menit. Kondisi ini dapat dipengaruhi oleh tingginya jumlah resep racikan, keterbatasan sumber daya manusia pada jam-jam sibuk, proses peracikan yang membutuhkan waktu lebih lama dibandingkan obat nonracikan, serta adanya antrean pelayanan farmasi yang tinggi.

Tabel 3.26 PDSA Capaian Waktu Tunggu Obat Racikan Kurang Dari 60 Menit

Problem	Pada Triwulan I tahun 2026, indikator waktu tunggu obat racikan kurang dari 60 menit menunjukkan capaian yang belum memenuhi standar yang ditetapkan yaitu 100%. Capaian pada bulan Januari sebesar 89,62%, mengalami penurunan menjadi 82,66% pada bulan Februari, kemudian meningkat sedikit menjadi 83,15% pada bulan Maret. Rata-rata capaian triwulan sebesar 85,14%, sehingga masih terdapat gap sebesar 14,86% terhadap standar.
Plan	Meningkatkan capaian waktu tunggu obat racikan kurang dari 60 menit melalui optimalisasi alur pelayanan farmasi, pengaturan beban kerja petugas, dan pemantauan waktu pelayanan secara berkala.
Do	Melakukan evaluasi alur pelayanan resep racikan, mengoptimalkan pembagian tugas petugas farmasi, memprioritaskan proses peracikan sesuai urutan pelayanan, serta melakukan monitoring waktu tunggu obat setiap hari.
Study	Menganalisis hasil monitoring waktu tunggu, mengidentifikasi faktor penyebab keterlambatan pelayanan obat racikan, serta mengevaluasi efektivitas upaya perbaikan yang telah dilakukan.
Action	Menetapkan langkah perbaikan yang terbukti efektif sebagai standar pelayanan, melakukan pembinaan kepada petugas, serta melaksanakan monitoring berkelanjutan untuk mencapai target waktu tunggu yang ditetapkan.

Tabel 3.27 Rencana Tindak Lanjut

No	Rencana Kegiatan	Tujuan	Sasaran	Strategik	Pelaksana	Waktu
1	Evaluasi alur pelayanan resep racikan	Mengidentifikasi hambatan yang menyebabkan keterlambatan pelayanan	Instalasi Farmasi	Analisis proses pelayanan dan pemetaan kendala	Kepala Instalasi Farmasi, Tim Mutu	1-3 bulan
2	Monitoring waktu tunggu obat racikan secara rutin	Mengetahui kepatuhan terhadap target waktu pelayanan	Petugas Farmasi	Pencatatan dan evaluasi waktu pelayanan harian	Instalasi Farmasi	1-3 bulan
3	Sosialisasi dan optimalisasi pembagian tugas petugas farmasi	Meningkatkan efisiensi proses peracikan obat	Petugas Farmasi	Briefing, pembinaan, dan penyesuaian alur kerja	Kepala Instalasi Farmasi	1-3 bulan

BAB IV

HASIL KEGIATAN MUTU PRIORITAS UNIT

1. Instalasi Gawat Darurat

NO	JUDUL INDIKATOR MUTU	UNIT	Bulan			STANDAR	Ket
			Jan '26	Feb '26	Mar '26		
1	Ketidaklengkapan E-RM pengkajian awal IGD dan SPRI	IGD	-	54.72%	1.53%	0%	Tidak tercapai (Feb & Mar)
2	Kejadian ketidakpatuhan staf medis dalam penempatan pasien dengan EWS	IGD	-	0	0	0	Tercapai
3	Kejadian kesalahan asuhan medis dokter IGD	IGD	-	0	0	0	Tercapai

2. Instalasi Rawat Inap

NO	JUDUL INDIKATOR MUTU	UNIT	Bulan			STANDAR	Ket
			Jan '26	Feb '26	Mar '26		
1	Kejadian kesalahan asuhan medis DPJP	Rawat Inap	-	0	0	0	Tercapai
2	Angka Kejadian pasien tidak dilaksanakan visite	Rawat Inap	-	55.64%	29.92%	0%	Tidak tercapai (Feb & Mar)
3	Ketidaklengkapan e-rm asuhan pasien selama di rawat inap	Rawat Inap	-	60.71%	56.75%	0%	Tidak tercapai (Feb & Mar)

3. ICU dan HCU

NO	JUDUL INDIKATOR MUTU	UNIT	Bulan			STANDAR	Ket
			Jan '26	Feb '26	Mar '26		
1	Ketidaklengkapan e-rm asuhan pasien selama di ICU dan HCU	ICU / HCU	-	70.45%	0%	0%	Tidak tercapai (Feb)
2	Kejadian Kesalahan saat hand over (serah terima)	ICU / HCU	0	0	0	0	Tercapai
3	Kejadian Keterlambatan pemasangan intubasi pasien	ICU / HCU	0	0	1	0	Tidak Tercapai (Mar)
4	Angka pasien kembali ke perawatan intensive dengan kasus yang sama <72 jam	ICU/HCU	0	4	0	<3%	Tidak tercapai (Feb)

4. Instalasi Rawat Jalan

NO	JUDUL INDIKATOR MUTU	UNIT	Bulan			STANDAR	Ket
			Jan '26	Feb '26	Mar '26		

1	Kepatuhan DPJP terhadap Jadwal Praktek	Rawat Jalan	-	87.6%	84.62%	100%	Tidak tercapai (Feb & Mar)
2	Ketidaklengkapan e-rm asuhan pasien selama di rrawat jalan	Rawat Jalan	-	2.55%	2.58%	0%	Tidak tercapai (Feb & Mar)
3	Target Pasien PRB dan iterasi	Rawat Jalan	-	-	1.14%	100%	Tidak tercapai (Feb & Mar)
4	Kegagalan pelaksanaan layanan di rawat jalan (pasien gagal pelayanan atas kesalahan) setiap hari	Rawat Jalan	-	0	0	0	Tercapai

5. Fisioterapi

NO	JUDUL INDIKATOR MUTU	UNIT	Bulan			STANDAR	Ket
			Jan '26	Feb '26	Mar '26		
1	Kegagalan pelaksanaan layanan di rawat jalan (pasien gagal pelayanan atas kesalahan) setiap hari	Fisiotera pi	5	2	0	0	Tidak tercapai (Jan & Feb)
2	Pelayanan tidak sesuai program terapi	Fisotera pi	0%	0%	0%	0%	Tercapai

6. Maternitas

NO	JUDUL INDIKATOR MUTU	UNIT	Bulan			STANDAR	Ket
			Jan '26	Feb '26	Mar '26		
1	Ketidaklengkapan e-rm asuhan pasien selama di maternitas	Maternit as	11%	13%	15%	0%	Tidak tercapai (Jan-Mar)
2	Angka kematian ibu	Maternit as	0,8%	0%	0%	0%	Tidak tercapai (Januari)
3	Kejadian perdarahan post partum	Maternit as	3	3	2	0	Tidak tercapai (Jan-Mar)
4	Angka Kejadian partus macet	Maternit as	18.5%	31.3%	33.3%	<10%	Tidak tercapai (Jan-Mar)
5	Kejadian eklamsi	Maternit as	3	0	0	0	Tidak tercapai (Jan)
6	Kejadian pre eklamsi	Maternit as	0	1	1	0	Tidak tercapai (Feb-Mar)
7	Kejadian infeksi nifas	Maternit as	0	0	0	0	Tercapai

7. Neonatologi

NO	JUDUL INDIKATOR MUTU	UNIT	Bulan			STANDAR	Ket
			Jan '26	Feb '26	Mar '26		

1	Angka Kematian Bayi	Neonatology	0%	0%	1.59%	0%	Tidak tercapai (Mar)
2	Kejadian Keterlambatan pemasangan Intubasi pada pasien dengan indikasi	Neonatology	0	0	0	0	Tercapai
3	Kejadian SHK yang di tolak Dinkes	Neonatology	0	0	0	0	Tercapai

8. Instalasi Kamar Operasi

NO	JUDUL INDIKATOR MUTU	UNIT	Bulan			STANDAR	Ket
			Jan '26	Feb '26	Mar '26		
1	Kejadian re operasi	IKO	0	0	0	0	Tercapai
2	Ketidaklengkapan pengisian e-rm laporan operasi dan anestesi sedasi pasien selama di IKO	IKO	-	9.32%	1.49%	0%	Tidak tercapai (Feb-Mar)
3	Kejadian kegagalan pembiusan SAB, sehingga prosedur dialihkan menjadi pembiusan GA	IKO	0	0	0	0	Tercapai

9. Laboratorium

NO	JUDUL INDIKATOR MUTU	UNIT	Bulan			STANDAR	Ket
			Jan '26	Feb '26	Mar '26		
1	Keterlambatan hasil patologi anatomi sesuai dengan regulasi	Laboratorium	0	24	27	0	Tidak tercapai (Feb-Mar)
2	Surveilans harian hemovigilance "Kejadian Reaksi Transfusi"	Laboratorium	100%	100%	100%	100%	Tercapai
3	Ketersediaan kantong darah sesuai golongan darah	Laboratorium	98.5%	100%	100%	100%	Tidak tercapai (Jan)

10. Radiologi

NO	JUDUL INDIKATOR MUTU	UNIT	Bulan			STANDAR	Ket
			Jan '26	Feb '26	Mar '26		
1	Kejadian ketidakcocokan hasil bacaan radiologi dengan klinis pasien	Radiologi	0	16	5	0	Tidak tercapai (Feb-Mar)
2	Kejadian keterlambatan hasil radiologi sesuai dengan regulasi	Radiologi	0	40	30	0	Tidak tercapai (Feb-Mar)

11. Instalasi Gizi

NO	JUDUL INDIKATOR MUTU	UNIT	Bulan	STANDAR	Ket
----	----------------------	------	-------	---------	-----

			Jan '26	Feb '26	Mar '26		
1	Kepatuhan penggunaan alat pelindung diri (APD) oleh petugas pengolahan	Instalasi Gizi	-	91.09%	87.76%	100%	Tidak tercapai (Feb-Mar)
2	Kepatuhan identifikasi pasien oleh penyaji	Instalasi Gizi	-	100%	100%	100%	Tercapai
3	Angka Kelengkapan Pengkajian Gizi	Instalasi Gizi	100%	100%	100%	100%	Tercapai
4	Kejadian kesalahan pemberian diet	Instalasi Gizi	2	1	1	0	Tidak tercapai (Jan-Mar)
5	Kejadian adanya benda asing dalam makanan	Instalasi Gizi	0	0	0	0	Tercapai
6	Kejadian makanan basi	Instalasi Gizi	1	1	0	0	Tidak tercapai (Jan & Feb)

12. Instalasi Farmasi

NO	JUDUL INDIKATOR MUTU	UNIT	Bulan			STANDAR	Ket
			Jan '26	Feb '26	Mar '26		
1	Angka keterlambatan penyediaan obat jadi rawat jalan >30 menit.	Farmasi	-	43.56%	43.06%	0%	Tidak tercapai (Feb-Mar)
2	Kejadian ketidakpatuhan retur obat rawat inap	Farmasi	0	0	0	0	Tercapai
3	Kejadian Kesalahan Penyiapan Obat	Farmasi	2	4	6	0	Tidak tercapai (Jan-Mar)
4	Kejadian Kesalahan Pemberian Obat	Farmasi	1	2	0	0	Tidak tercapai (Jan & Feb)
5	Kejadian Kesalahan Penulisan Etiket Obat	Farmasi	1	0	0	0	Tidak tercapai (Feb-Mar)
6	Kejadian Kesalahan Input E-Resep	Farmasi	1	4	0	0	Tidak tercapai (Jan & Feb)
7	Keterlambatan sediaan farmasi datang	Pengada an Farmasi	-	20.6%	28%	0%	Tidak tercapai (Feb-Mar)
8	Kesalahan pembelian sediaan farmasi	Pengada an Farmasi	-	0%	0%	0%	Tercapai
9	Angka selisih stok opname	Pengada an Farmasi	-	0.88%	0.73%	0%	Tidak tercapai (Feb-Mar)
10	Resptime memasukkan master barang baru 1X24 Jam	Pengada an Farmasi	-	93.75%	97.37%	≥95%	Tidak tercapai (Feb-Mar)

13. Komite PPI

NO	JUDUL INDIKATOR MUTU	UNIT	Bulan	STANDAR	Ket
----	----------------------	------	-------	---------	-----

			Jan '26	Feb '26	Mar '26		
1	IDO (Infeksi Daerah Operasi)	PPI	0%	0%	0%	≤ 2 %	Tercapai
2	IADP (Infeksi Aliran Darah Primer)	PPI	0%	0%	0%	≤3,5‰	Tercapai
3	VAP (Ventilation Associated Pneumonia)	PPI	0 ‰	0 ‰	1.82%	≤ 5,8 ‰	Tercapai
4	ISK (Infeksi Saluran Kencing)	PPI	0 ‰	0 ‰	0.81%	≤ 4,7 ‰	Tercapai
5	Infeksi Aliran Darah Perifer /ILI (Phlebitis)	PPI	0.35%	0.3%	0.17%	≤ 5 %	Tercapai
6	Angka Decubitus	PPI	0%	0%	9.09%	0%	Tercapai
7	Kejadian petugas tertusuk jarum bekas pasien (paparan)	PPI	0	0	0	0	Tercapai

14. SDM

NO	JUDUL INDIKATOR MUTU	UNIT	Bulan			STANDAR	Ket
			Jan '26	Feb '26	Mar '26		
1	Kejadian keterlambatan pengurusan SIP/SIK	SDM	0%	4.72%	0	0	Tidak tercapai (Jan & Feb)
2	Angka turn over staf	SDM	1.4%	0%	0.28%	0%	Tidak tercapai (Jan & Mar)

15. Instalasi Rekam Medis (Pendaftaran)

NO	JUDUL INDIKATOR MUTU	UNIT	Bulan			STANDAR	Ket
			Jan '26	Feb '26	Mar '26		
1	Kesalahan pendaftaran pasien	Pendaftar	-	25	25	0	Tidak tercapai (Feb-Mar)
2	Kejadian pasien BPJS TK tidak memasukkan dalam system E-PLKK	Pendaftar	-	4	1	0	Tidak tercapai (Feb-Mar)
3	Kejadian ketidaksesuaian tanggal pengunjungan pasien RI dengan SPRI	Pendaftar	-	0	1	0	Tidak tercapai (Feb-Mar)

16. K3RS

NO	JUDUL INDIKATOR MUTU	UNIT	Bulan			STANDAR	Ket
			Jan '26	Feb '26	Mar '26		
1	Ketidakpatuhan pembuatan PCRA	K3RS	-	0	0	0	Tercapai

17. Asuransi Center

NO	JUDUL INDIKATOR MUTU	UNIT	Bulan			STANDAR	Ket
			Jan '26	Feb '26	Mar '26		
1	Waktu pengajuan klaim	Asuransi Center	Tgl 5	Tgl 5	Tgl 5	Tgl 5 awal bulan	Tercapai
2	Klaim pending RJTL	Asuransi Center	0	-	-	<0.1%	Belum diisi
3	Klaim pending RITL	Asuransi Center	0	-	-	<1%	Belum diisi
4	Klaim tidak layak	Asuransi Center	0	-	-	0%	Belum diisi
5	Nilai Pengembalian Audit Klaim RJTL	Asuransi Center	0	-	-	<1 juta	Belum diisi
6	Nilai Pengembalian Audit Klaim RITL	Asuransi Center	0	-	-	<5 juta	Belum diisi
7	Nilai selisih negatif klaim RJTL	Asuransi Center	251.17 5.040	232.420. 655	151.929.7 83	<50 juta	Tidak tercapai (Jan-Mar)
8	Nilai selisih negatif klaim RITL	Asuransi Center	- 1.216. 032.65 4	-	-	<100 juta	Tidak tercapai (Jan)
9	Persentase readmisi pasien rawat inap	Asuransi Center	3.5%	1.8%	2.3%	0%	Tidak tercapai (Jan-Mar)
10	Angka kelengkapan berkas klaim di SIMRS	Asuransi Center	66.4%	58%	61.3%	100%	Tidak tercapai (Jan-Mar)

18. IPSRS

NO	JUDUL INDIKATOR MUTU	UNIT	Bulan			STANDAR	Ket
			Jan '26	Feb '26	Mar '26		
1	Waktu tanggap respon dan penanganan pelaporan kerusakan unit	IPSRS	96.83 %	98.08%	88.28%	100%	Tidak tercapai (Jan-Mar)
2	Kejadian kerusakan sarana prasarana	IPSRS	124	156	145	0	Tidak tercapai (Jan-Mar)

19. Gudang Umum

NO	JUDUL INDIKATOR MUTU	UNIT	Bulan			STANDAR	Ket
			Jan '26	Feb '26	Mar '26		
1	Ketidakpatuhan pengambilan barang oleh unit	Gudang Umum	4	8	1	0	Tidak tercapai (Jan-Mar)

20. Cleaning Service

NO	JUDUL INDIKATOR MUTU	UNIT	Bulan			STANDAR	Ket
			Jan '26	Feb '26	Mar '26		
1	Resptime menanggapi keluhan unit <10 menit	Cleaning Service	90.91 %	79.1%	84.62%	≥ 90%	Tidak tercapai (Feb-Mar)

21. Sekretariat

NO	JUDUL INDIKATOR MUTU	UNIT	Bulan			STANDAR	Ket
			Jan '26	Feb '26	Mar '26		
1	Angka ketidaklengkapan pengumpulan dokumen meeting RS (saat akhir rapat)	Sekretariat	25%	0%	0%	0%	Tidak tercapai (Jan)

22. CSSD dan Laundry

NO	JUDUL INDIKATOR MUTU	UNIT	Bulan			STANDAR	Ket
			Jan '26	Feb '26	Mar '26		
1	Kejadian linen ruang perawatan hilang	Laundry	0	16	38	0	Tidak tercapai (Feb-Mar)
2	Kejadian tercampur benda asing	Laundry	1	0	4	0	Tidak tercapai (Jan & Mar)
3	Kejadian keterlambatan penyediaan kasa steril	CSSD	2	0	0	0	Tidak tercapai (Jan)
4	Kejadian ditemukannya instrument hilang atau kurang	CSSD	0	0	2	0	Tidak tercapai (Mar)

23. IT

NO	JUDUL INDIKATOR MUTU	UNIT	Bulan			STANDAR	Ket
			Jan '26	Feb '26	Mar '26		
1	Kejadian CCTV tidak terecord	IT	0	0	2	0	Tidak tercapai (Mar)
2	Kejadian Komputer dan internet lemot	IT	60	53	17	0	Tidak tercapai (Jan-Mar)

24. Kamar Jenazah

NO	JUDUL INDIKATOR MUTU	UNIT	Bulan			STANDAR	Ket
			Jan '26	Feb '26	Mar '26		

1	Ketidakpatuhan pencatatan buku transit jenazah	Kamar Jenazah	0%	0%	0%	0%	Tercapai
---	--	---------------	----	----	----	----	----------

25. Driver

NO	JUDUL INDIKATOR MUTU	UNIT	Bulan			STANDAR	Ket
			Jan '26	Feb '26	Mar '26		
1	Kejadian permintaan driver yang bersamaan	Driver	0	4	1	0%	Tidak tercapai (Feb-Mar)
2	Kejadian Oncall driver	Driver	3	5	2	0	Tidak tercapai (Jan-Mar)
3	Penggunaan ambulance Luar RS	Driver	12	11	10	0	Tidak tercapai (Jan-Mar)

26. Security

NO	JUDUL INDIKATOR MUTU	UNIT	Bulan			STANDAR	Ket
			Jan '26	Feb '26	Mar '26		
1	Kelolosan tamu tidak menggunakan kartu visitor	Security	1	0	1	0	Tidak tercapai (Jan & Mar)
2	Kejadian ketidaktertiban pengunjung rawat inap	Security	15	14	13	0	Tidak tercapai (Jan-Mar)

27. Kasir

NO	JUDUL INDIKATOR MUTU	UNIT	Bulan			STANDAR	Ket
			Jan '26	Feb '26	Mar '26		
1	Kesalahan pelunasan yang dilakukan	Kasir	2	5	5	0	Tidak tercapai (Jan-Mar)
2	Keterlambatan pelunasan pembayaran	Kasir	1	1	0	0	Tidak tercapai (Jan & Feb)
3	kejadian pemulangan pasien rawat inap lebih dari 15 menit	Kasir	0	4	13	0	Tidak tercapai (Feb & Mar)

28. Humas

NO	JUDUL INDIKATOR MUTU	UNIT	Bulan			STANDAR	Ket
			Jan '26	Feb '26	Mar '26		
1	Keterlambatan perpanjangan perjanjian kerja sama	Humas	0	0	0	0	Tercapai

29. Primantara

NO	JUDUL INDIKATOR MUTU	UNIT	Bulan			STANDAR	Ket
			Jan '26	Feb '26	Mar '26		
1	Kejadian komplain pasien karena keterlambatan pengantaran obat	Primantara	1	1	0	0	Tidak tercapai (Jan & Feb)

30. Tim PKRS

NO	JUDUL INDIKATOR MUTU	UNIT	Bulan			STANDAR	Ket
			Jan '26	Feb '26	Mar '26		
1	Kepatuhan PPA dalam pengisian form edukasi kolaborasi	PKRS	-	-	87%	100%	Tidak tercapai (Mar)
2	Angka Kelengkapan Dokumentasi Metode SBAR dan Konfirmasi "Read Back" pada Instruksi Verbal	PKRS	-	-	93%	100%	Tidak tercapai (Mar)
3	Angka Kepatuhan Petugas dalam Survei kelengkapan Form Edukasi Kolaborasi Oleh PPA	PKRS	-	-	90%	100%	Tidak tercapai (Mar)
4	Angka kepatuhan petugas dalam memberikan edukasi Kelompok	PKRS	-	-	-	100%	Belum diisi

31. PIPP

NO	JUDUL INDIKATOR MUTU	UNIT	Bulan			STANDAR	Ket
			Jan '26	Feb '26	Mar '26		
1	Angka kepuasan pasien peserta BPJS	PIPP	99.89 %	100%	100%	100%	Tidak tercapai (Jan)
2	Angka terhubungnya display TT dengan mobile JKN	PIPP	100%	100%	100%	≥ 90%	Tercapai
3	Angka terhubungnya operasi dengan mobile JKN	PIPP	100%	100%	100%	≥ 90%	Tercapai

32. PROGNAS TB

NO	JUDUL INDIKATOR MUTU	UNIT	Bulan			STANDAR	Ket
			Jan '26	Feb '26	Mar '26		
1	Angka Pasien Terkonfirmasi Bakteriologis	PROGNAS TB	100%	100%	100%	100%	Tercapai

33. PROGNAS KB

NO	JUDUL INDIKATOR MUTU	UNIT	Bulan	STANDAR	Ket
----	----------------------	------	-------	---------	-----

			Jan '26	Feb '26	Mar '26		
1	Angka capaian pelayanan KB per metode kontrasepsi, baik Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) dan Non MKJP	PROGN AS KB	25.6%	7.44%	10.6%	100%	Tidak tercapai (Jan-Mar)
2	Angka capaian pelayanan KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran	PROGN AS KB	23.9%	9.9%	22.6%	70%	Tidak tercapai (Jan-Mar)
3	Kejadian tidak dilakukannya KB Pasca Persalinan pada ibu baru bersalin dan KB Pasca Keguguran pada Ibu pasca keguguran	PROGN AS KB	92	94	89	0	Tidak tercapai (Jan-Mar)

34. **PROGNAS STUNTING**

NO	JUDUL INDIKATOR MUTU	UNIT	Bulan			STANDAR	Ket
			Jan '26	Feb '26	Mar '26		
1	Angka Pelaksanaan kunjungan rumah dan PKM pasien Stunting & Wasting	PROGN AS STUNTING	-	-	-	100%	Belum diisi
2	Angka Kepatuhan Petugas dalam Memberikan edukasi kelompok sebagai upaya Pencegahan Stunting & Wasting (4x/bln)	PROGN AS STUNTING	-	-	-	100%	Belum diisi

35. **PROGNAS HIV**

NO	JUDUL INDIKATOR MUTU	UNIT	Bulan			STANDAR	Ket
			Jan '26	Feb '26	Mar '26		
1	Angka kepatuhan petugas dalam melakukan skrining dan testing pasien dengan resiko HIV/AIDS	PROGN AS HIV	100%	100%	100%	100%	Tercapai

BAB V
INSIDEN KESELAMATAN PASIEN

Rekapitulasi IKP yang terjadi pada Triwulan I Tahun 2026

Berikut merupakan rekapitulasi IKP yang terjadi pada Triwulan I Tahun 2026

Tabel 5.1 Rekapitulasi IKP yang terjadi pada Triwulan II Tahun 2026

	KPC	KNC	KTC	KTD	SENTINEL	JUMLAH
JANUARI	5		3			8
FEBRUARI	6	1	4	2		11
MARET	2		2	1		5
JUMLAH	13	1	9	3	0	24

Berdasarkan tabel 5.1 diketahui bahwa terjadi jenis insiden terbanyak yang terjadi pada Triwulan I Tahun 2026 adalah Kejadian Potensial Cedera sebanyak 13 insiden. Kejadian Nyaris Cedera pada Triwulan I Tahun 2025 sebanyak 1 insiden, Kejadian Tidak Cedera sebanyak 9 insiden, dan Kejadian Tidak Diharapkan sebanyak 3 insiden. Sementara untuk Kejadian Sentinel tidak terjadi selama tahun 2025.

Berikut merupakan insiden keselamatan pasien yang terjadi pada Triwulan I Tahun 2025.

5.1 Laporan IKP Bulan Januari

No.	TGL KEJADIAN	STAF YG TERLIBAT		Jenis IKP	KRONOLOGI	TINDAK LANJUT
		NAMA	UNIT			

1.	6 Januari		IGD	KPC	Terdapat tumpahan yang dapat menimbulkan risiko jatuh pada pasien maupun petugas	- Sosialisasi pencegahan risiko jatuh - Penyediaan rambu "lantai basah" - Penegasan SOP kebersihan & respon cepat tumpahan
2.	8 Januari		IGD	KPC	Terdapat tumpahan yang dapat menimbulkan risiko jatuh pada pasien maupun petugas	- Sosialisasi pencegahan risiko jatuh - Penyediaan rambu "lantai basah" - Penegasan SOP kebersihan & respon cepat tumpahan
3.	14 Januari		IRNA 2C	KPC	Terdapat tumpahan yang dapat menimbulkan risiko jatuh pada pasien maupun petugas	- Sosialisasi pencegahan risiko jatuh - Penyediaan rambu "lantai basah" - Penegasan SOP kebersihan & respon cepat tumpahan
4.	19 Januari	dr. Yuniar Ardi San	IGD	KTC	Anamnesis dan pemeriksaan fisik tidak sesuai	Penguatan supervisi dokter IGD
5.	19 Januari	dr. Naufal, Laras	Farmasi	KTC	Kesalahan input e-resep	Koordinasi dengan komite medik dan kepala bidang pelayanan medis
6.	19 Januari		IGD	KPC	Terdapat tumpahan yang dapat menimbulkan risiko jatuh pada pasien maupun petugas	- Sosialisasi pencegahan risiko jatuh - Penyediaan rambu

						“lantai basah” Penegasan SOP kebersihan & respon cepat tumpahan
7.	26 Januari	Laras, Noviati, Ria	Farmasi	KTC	Kesalahan pemberian obat	- Refresh SOP e-resep - Double check sebelum validasi resep - Edukasi keselamatan obat
8.	28 Januari	Iqbal	IRNA 234A	KPC	Tidak melakukan advice dokter sesuai jam yang diadvicedkan	- Penguatan komunikasi DPJP & perawat - Monitoring pelaksanaan advice - Edukasi patient safety

5.2 Laporan IKP Bulan Februari

No.	TGL KEJADIAN	STAF YG TERLIBAT		Jenis IKP	KRONOLOGI	TINDAK LANJUT
		NAMA	UNIT			
1.	2 Februari		Farmasi	KTC	Kesalahan pemberian obat karena kesalahan order permintaan obat dan semua petugas farmasi tidak melakukan doubel chek	- Melakukan pengecekan ulang pada saat packing resep dan sebelum diserahkan pada pasien

						- Peningkatan kedisiplinan penulisan paraf pada labal ISEP sehingga dapat diketahui petugas yang melakukan input, penyiapan, etiket maupun KIE
2.	2 Februari	Elis, Defi, Lilis	Farmasi	KTC	Kesalahan pemberian obat karena obat pasien tertinggal (tidak diberikan pada pasien)	- Melakukan pengecekan ulang pada saat packing resep dan sebelum diserahkan ke pasien - Peningkatan kedisiplinan penulisan paraf pada labal ISEP sehingga dapat diketahui petugas yang melakukan input, penyiapan, etiket maupun KIE
3.	5 Februari	Dokter Dicky		KPC	Kesalahan input e-resep	Koordinasi dengan komite medik dan kepala bidang pelayanan medis

4.	5 Februari	Dokter Zora		KNC	Kesalahan input e-resep	Koordinasi dengan komite medik dan kepala bidang pelayanan medis
5.	5 Februari	Dokter icky		KPC	Kesalahan input e-resep	Koordinasi dengan komite medik dan kepala bidang pelayanan medis
6.	10 Februari	Dokter Humaira		KNC	Kesalahan input e-resep	Koordinasi dengan komite medik dan kepala bidang pelayanan medis
7.	5 Februari			KTC	Kejadian makanan basi	- Melakukan QC secara keseluruhan terhadap makanana pasien - Tidak membuat bahan makanan setengah jadi jauh jauh hari - Selalu memberi label tanggal pembuatan makanan setengah jadi

8.	28 Februari	Alfira		KTC	Pasien mendapat makan yang tidak sesuai advice karena permintaan belum di update oleh DPJP	- Membaca ulang secara keseluruhan dari daftar diet yang di update - Fokus bekerja / tidak bermain hp di luar urusan pekerjaan
9.	5 Februari 2026		Laboratorium	KPC	Ditemukan tumpahan air yang dapat menimbulkan risiko jatuh pada petugas maupun pasien	Segera memasang tanda risiko jatuh dan melaporkan kepada tim cleaning service
10.	6 Februari 2026		IGD	KPC	Ditemukan tumpahan air yang dapat menimbulkan risiko jatuh pada petugas maupun pasien	Segera memasang tanda risiko jatuh dan melaporkan kepada tim cleaning service
11.	6 Februari 2026		IRNA 7A	KPC	Ditemukan tumpahan air kencing yang dapat menimbulkan risiko jatuh pada pasien	Segera memasang tanda risiko jatuh dan melaporkan kepada tim cleaning service
12.	7 Februari		IGD, IRNA 5C	KTD	Miskomunikasi terkait kondisi pasien dari FKTP sehingga pasien yang seharusnya dirawat oleh Dokter Bedah tidak dirawat oleh Dokter Bedah karena	Pasien dirawat oleh dokter IPD

					kondisi pasien saat dirujuk tidak menunjukkan kegawatan bedah sehingga pasien mengalami delay pelayanan.	
13.	10 Februari 2026		Laboratorium	KPC	Ditemukan tumpahan air yang dapat menimbulkan risiko jatuh pada petugas maupun pasien	Segera memasang tanda risiko jatuh dan melaporkan kepada tim cleaning service
14.	27 Februari 2026	Sahri, Fifi	IRNA 4A	KTD	Kejadian pasien jatuh di ruangan karena pasien tidak di tunggu oleh keluarga dan keluarga tidak menitipkan kepada perawat, sehingga perawat tidak memindahkan pasien ke kamar yang dekat dengan NS	Melakukan KIE pada keluarga untuk menjaga pasien dan melakukan edukasi terkait upaya pencegahan risiko jatuh

5.3 Laporan IKP Bulan Maret

No.	TGL KEJADIAN	STAF YG TERLIBAT		Jenis IKP	KRONOLOGI	TINDAK LANJUT
		NAMA	UNIT			

1.	1 Maret	Alfira	Instalasi Gizi	KTC	Kejadian makanan basi karena ahli gizi kurang teliti saat menginput update diet di komputer	Peningkatan kedisiplinan staf untuk membaca ulang secara keseluruhan dari daftar diet yang sudah di update dan fokus saat bekerja.
2.	1 Maret	dr. Akhmad Syahrir, Laras	Farmasi	KTC	Kesalahan input e-resep	- Koordinasi dengan komite medik dan kepala bidang pelayanan medis - Koordinasi dengan kepala bidang pelayanan medis dan kepala ruang poli untuk mengecek template resep agar dirubah dan tidak terjadi kesalahan berulang.
3.	2 Maret		Farmasi	KPC	Kesalahan input e-resep	Koordinasi dengan komite medik dan kepala bidang pelayanan medis
4.	10 Maret		IRNA 3C Anak	KPC	Tidak tertulisnya pengkajian alergi obat dari IGD sehingga tidak teroper ke ruangan	Refreshing di IGD mengenai input di e-rm mengenai alergi obat
5.	24 Maret	Elok, Bd. Deya	Maternitas	KTD	Pelaksanaan tindakan kristeller untuk membantu persalinan	- Audit maternitas - Pemahaman ada aturan dari dinkes tidak boleh kristeller - KIE tertulis dan ditandatangani kepada keluarga sebelum tindakan persalinan untuk semua pasien bersalin - Adfis DPJP tindakan kristeller untuk membantu persalinan

						- Inform consent jika dilakukan
--	--	--	--	--	--	---------------------------------

BAB VI

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

- a. Indikator Mutu Nasional: Terdapat 8 dari 13 indikator yang sudah mencapai standar. Empat (4) indikator yang belum tercapai yaitu:
 - (1) Kepatuhan Penggunaan APD tercapai 96,40% dari target 100%
 - (2) Kepatuhan Identifikasi Pasien tercapai 99,89% dari target 100%
 - (3) Kepatuhan Waktu Visite Dokter tercapai 68,35% dari target 80%
 - (4) Kepatuhan Terhadap Alur Klinis (CP) tercapai 18,75% dari target 80%
- b. Indikator Mutu Prioritas Rumah Sakit: Terdapat 4 dari 12 indikator yang sudah mencapai standar. Hal ini berarti lebih dari 50% indikator yang belum mencapai standar. Indikator yang belum mencapai target yaitu:
 - (1) Kepatuhan penempelan label obat LASA dan obat-obatan high alert di rawat inap tercapai 92,90% dari target 100%
 - (2) Kepatuhan petugas kesehatan melakukan 6 langkah cuci tangan tercapai 85,91% dari target 100%
 - (3) Kepatuhan pemasangan handrail dan penguncian roda brankar tercapai 92,08% dari target 100%
 - (4) Kepatuhan Pengisian Form Discharge Planing pasien DM dengan ulkus tercapai 12,50% dari target 100%
 - (5) Kepatuhan Pengisian Form Edukasi pada pasien DM dengan ulkus tercapai 21,48% dari target 100%
 - (6) Kepatuhan PPK dan CP Pasien DM tercapai 12,05% dari target 100%
 - (7) Kejadian complain pasien/keluarga di google review tercapai 3 dari target 0 kejadian
 - (8) Waktu tunggu obat racikan <60 menit tercapai 83,15% dari target 100%
- c. Beberapa Indikator Mutu Unit yang belum mencapai target yaitu:
 - (1) IGD: Ketidaklengkapan e-rm pengkajian awal IGD dan SPRI tercapai 1,53% dari target 0%
 - (2) IRNA: Ketidaklengkapan e-rm asuhan pasien selama di rawat inap tercapai 56,75% dari target 0%.
 - (3) ICU/HCU: Kejadian keterlambatan pemasangan intubasi pasien tercapai 1 kejadian dari target 0 kejadian.
 - (4) IRJA: Kepatuhan DPJP terhadap jadwal praktek tercapai 84,62% dari target 100%
 - (5) Maternitas: ketidaklengkapan e-rm asuhan pasien selama di maternitas tercapai 15% dari target 0%.
 - (6) Neonatologi: Angka kematian bayi tercapai 1,59% dari target 0%.
 - (7) IKO: Ketidaklengkapan pengisian e-rm laporan operasi dan anestesi sedasi pasien selama di IKO tercapai 1,49% dari target 0%.
 - (8) Laboratorium: Keterlambatan patologi anatomi sesuai dengan regulasi tercapai 27 kejadian dari target 0 kejadian.
 - (9) Radiologi: Kejadian ketidakcocokan hasil bacaan radiologi dengan klinis pasien tercapai 5 kejadian dari target 0 kejadian.
 - (10) Instalasi gizi: Kepatuhan penggunaan APD oleh petugas pengolahan tercapai 87,76% dari target 100%
 - (11) Farmasi: Angka keterlambatan penyediaan obat jadi rawat jalan >30 menit tercapai 43,06% dari target 0%.
 - (12) SDM: Angka turn over staf tercapai 0,28% dari target 0%.
 - (13) Instalasi RM (Pendaftaran): Kejadian pasien BPJS TK tidak memasukkan dalam system E-PLKK tercapai 1 kejadian dari target 0 kejadian.

- (14) Asuransi Center: Angka kelengkapan berkas di SIMRS tercapai 61,3% dari target 100%.
 - (15) IPSRS: Kejadian kerusakan sarana dan prasaran tercapai 145 kejadian dari target 0 kejadian.
 - (16) Gudang umum: Ketidapatuhan pengambilan barang oleh unit tercapai 1 kejadian dari target 0 kejadian.
 - (17) Cleaning Service: Resptime menanggapi keluhan unit <10 menit tercapai 84,62% dari target 90%.
 - (18) Laundry: Kejadian tercampur benda asing tercapai 2 kejadian dari target 0 kejadian.
 - (19) CSSD: Kejadian ditemukannya instrument hilang atau kurang tercapai 2 kejadian dari target 0 kejadian
 - (20) IT: Kejadian CCTV tidak terecord terdapat 2 kejadian dari target 0 kejadian.
 - (21) Driver: Penggunaan ambulans luar RS terdapat 10 kejadian dari target 0 kejadian.
 - (22) Security: Kejadian ketidaktertiban pengunjung rawat inap terdapat 13 kejadian dari target 0 kejadian.
 - (23) Kasir: Kesalahan pelunasan yang dilakukan terdapat 5 kejadian dari target 0 kejadian.
 - (24) Tim PKRS: Kepatuhan PPA dalam pengisian form edukasi kolaborasi tercapai 87% dari target 100%.
- d. Terdapat 27 kejadian IKP yang terjadi selama Bulan Januari sampai Maret Tahun 2026, yang terdiri dari 3 KTD, 1 KNC, dan 14 KPCS.

4.2 Penutup

Demikian Laporan Komite Mutu rumah sakit di Rumah Sakit Prima Husada Malang Triwulan 1 Tahun 2026. Upaya yang dilakukan adalah upaya maksimal yang bisa dikerjakan saat ini, tentunya upaya yang berkesinambungan dan tidak mengenal lelah terus dilakukan sehingga tercapai hasil tertinggi bagi semua komponen pemberi dan pengguna layanan rumah sakit.

Malang, 12 April 2026

Mengetahui,

Direktur RS Prima Husada Malang,



dr. Resti Lestantini, M.Kes

Ketua Komite Mutu



**dr. Diah Puspita Rifasanti,
Sp.M**